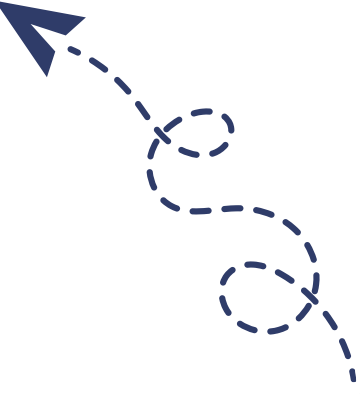




قناة تانية تمريضيانو على التليجرام



الاستجابة المناعية

ترتبط الميكروبات المعدية والبشر بصراع معقد ومستمر. المراوغة و يتم مواجهة الآليات المميزة للميكروبات المسببة للأمراض عن طريق الجهاز المناعي البشري. عندما تسود الميكروبات، يحدث المرض؛ ومن ناحية أخرى، عندما ينجح الجهاز المناعي، الإنسان يبقى على قيد الحياة.

❖ طرق مقاومة الجسم للأمراض:

المناعة الطبيعية (المناعة الفطرية)	المناعة المكتسبة (المناعة التكيفية)
1. الجلد والأغشية المخاطية.	1. الجهاز المناعي المخاطي (يقع باير)
2. مكمل	2. الأجسام المضادة
3. العدلات، البلاعم	3. المكونات الخلوية (الخلايا الليمفاوية B، T)

❖ تنقسم المناعة المكتسبة إلى:

➤ النوع الأول: المناعة المكتسبة النشطة

وبحدث ذلك عندما يتعرض الجهاز المناعي البشري لـ (مستضد)، مما يؤدي إلى إنتاج (الأجسام المضادة) وكذلك تكوين خلايا الذاكرة مثل (الذاكرة المعتمدة على الخلايا الليمفاوية التائية).

أمثلة: التحصين بالميكروبات الحية المضعفة أو الميتة أو سمومها (التوكسويد).

➤ النوع الثاني: المناعة المكتسبة السلبية

يحدث هذا عندما يتلقى الشخص أجسامًا مضادة جاهزة أو خلايا مناعية من شخص آخر.

مثال: شخص يتلقى الغلوبولين المناعي.

الفصل الأول

أمراض القلب والأوعية الدموية

الذبحة الصدرية

➤ تعريف:

وهو ألم شديد تحت عظم الصدر (عظم القص)، ويوصف ألم الذبحة الصدرية بأنه الضغط أو الضغط أو الحرق في الصدر.

➤ الأسباب:

يرتبط حدوث الذبحة الصدرية بتضييق الشرايين التاجية (هناك نوعان رئيسيان الشرايين التاجية)، وهو ما يعرف بتصلب الشرايين، ويحدث بشكل متكرر في:

1. السمنة المفرطة.
2. مرض السكري.
3. ارتفاع نسبة الدهون الثلاثية والكوليسترول في الدم.
4. ارتفاع ضغط الدم.
5. أسباب وراثية.
6. الإفراط في تناول الدهون الحيوانية مثل الزبدة والزيت... بشكل متكرر.
7. الإفراط في التدخين.
8. قلة النشاط البدني.

➤ ما هو تصلب الشرايين:

وهو ترسب الدهون والكوليسترول تحت الجدار الداخلي للشرايين، مما يؤدي إلى تضيق الشريان ونقص الأكسجين.

الأعراض:

- 1- يؤثر على الرجال أكثر من النساء.
- 2- وجود ألم تحت عظمة الصدر، ويزداد الألم مع ممارسة الرياضة - تناول الطعام - عند التعرض إلى البرد الشديد - ويحدث أيضًا أثناء الراحة. ينتشر الألم بشكل خاص إلى إحدى الذراعين - الرسغ - الكتف - الأسنان.
- 3- يصاحب الألم بعض الأعراض مثل التعرق والغثيان.

➤ تشخيص الذبحة الصدرية:

1. تخطيط القلب المنتظم أو تخطيط القلب الإجهادي.
2. المسح النووي.
3. استخدام قسطرة القلب.

➤ العلاج:

1. طمأنة المريض.
2. الإقلاع عن التدخين - تجنب التوتر العصبي.
3. إنقاص الوزن - ممارسة الرياضة - التحكم في ضغط الدم - التحكم في نسبة السكر في الدم.
4. تقليل الدهون الحيوانية والملح في الطعام.
5. استخدام موسعات الأوعية الدموية الشريانية مثل النتروجليسرين (إيزورديل 5 ملغ) تحت اللسان.
6. إعطاء أدوية لخفض الكوليسترول (أتور) - الأسبرين 150 ملغ، قرصين بعد الغداء.
7. قسطرة القلب الشريانية - لتوسيع الشرايين أو وضع دعامة أو إجراء جراحي لاستبدالها الشرايين (CABG).

احتشاء عضلة القلب

تعريف:

هو ألم شديد في الصدر يشبه ألم الذبحة الصدرية ولكنه أطول مدة وأكثر شدة، يصاحبه تعرق غزير - غثيان - وخوف شديد على المريض.

الأسباب:

نفس أسباب الذبحة الصدرية - ولكن هناك انسداد كامل في الشريان التاجي يؤدي إلى موت جزء من عضلة القلب.

الأعراض:

1. ألم شديد تحت عظمة الصدر.
2. ينتشر الألم إلى الذراع الأيسر - الكتف والرقبة.
3. في بعض الأحيان يكون الألم عبارة عن إحساس بالحرقان في المعدة.
4. التعرق - الغثيان - القيء - والأطراف باردة.

المضاعفات:

- 1- قصور القلب - الوذمة الرئوية.
- 2- عدم انتظام ضربات القلب (اضطرابات ضربات القلب).
- 3- انتشار الجلطة إلى أجزاء أخرى.

التشخيص:

- 1- ESR - CBC (تعداد الدم الكامل).
- 2- إنزيمات القلب . سي بي كيه
- 3- تخطيط القلب الكهربائي المنتظم.
- 4- الأشعة السينية للصدر – الموجات فوق الصوتية للقلب (تخطيط صدى القلب).

العلاج:

- 1- الدخول إلى وحدة رعاية القلب (CCU).
- 2- الأكسجين المرطب - أمبولة المورفين.
- يتم إعطاء أمبولة الهيبارين 3-4 IV ساعات.
- 4- يتم إعطاء أقراص الأسبرين أو مضادات التخثر مثل دينديفان.
- 5- في بعض الحالات يتم استعمال دواء ستريبتوكيناز - لإذابة الجلطة.
- 6- إجراء قسطرة القلب وإجراء توسيع أو رأب الأوعية الدموية للشرايين التاجية
- 7- ضمان التحكم في مستوى السكر - الدهون - وضغط الدم.
- 8- أمبولة النتروجليسرين (ترديدل).
- 9- علاج المضاعفات مثل عدم انتظام ضربات القلب وفشل القلب.

ارتفاع ضغط الدم

تعريف:

يتم تشخيص ارتفاع ضغط الدم عندما تكون قراءة ضغط الدم 140/90 أو أكثر في ثلاث حالات مختلفة قراءات.

الأسباب:

- 1- النوع الأولي (الأساسي) والذي يمثل أكثر من 90% من الحالات وأسبابه (السمنة - العوامل الوراثية - تناول كميات كبيرة من الملح في الطعام - التدخين).
- 2- النوع الثانوي والذي يرجع إلى:
 - أ- أمراض الكلى مثل الالتهابات - تضيق الشريان الكلوي.
 - ب- اضطرابات الغدة الدرقية (فرط نشاط الغدة الدرقية).
 - ج- اضطرابات الغدة الكظرية.
 - د- أورام المخ.
 - هـ- استخدام الأدوية مثل الكورتيزون.

الأعراض:

- 1- لا توجد أعراض محددة في معظم الحالات. (غالبًا ما يتم اكتشاف ارتفاع ضغط الدم بالصدفة).
- 2- التعب العام.
- 3- الصداع - عدم وضوح الرؤية.
- 4- نزيف الأنف (نزيف الأنف) - وجود دم في البول (دم في البول)

المضاعفات:

- 1- تضخم القلب وفشل القلب. 2- عدم انتظام ضربات القلب (اضطراب ضربات القلب). 3- نزيف في المخ.
- 4- الفشل الكلوي الحاد أو المزمن.
- 5- ضعف البصر بسبب إصابة الشبكية

التشخيص:

- 1- صورة الدم الكاملة - قياس نسبة السكر في الدم - اختبار اليوريا في الدم - الكرياتينين - الكوليسترول - الدهون الثلاثية.
- 2- فحص قاع العين.
- 3- تخطيط صدى القلب (الموجات فوق الصوتية على القلب).
- 4- الأشعة السينية للصدر.
- 5- تخطيط القلب.

العلاج:

- 1- علاج الأسباب المؤدية إلى ارتفاع ضغط الدم.
- 2- تجنب التوتر والقلق النفسي، ويسمح باستخدام المهدئات.
- 3- تقليل الوزن الزائد.
- 4- تقليل الملح في الطعام.
- 5- ممارسة التمارين البسيطة مثل المشي.
- 6- الإقلاع عن التدخين.
- 7- العلاج بالأدوية مع مراقبة ضغط الدم بشكل دوري. أمثلة:

▪ إبيلات

▪ إنديرال (بروبرانولول).

▪ كابوتين (كابتوبريل).

قصور القلب

تعريف

هو فشل القلب في ضخ كمية كافية من الدم إلى أنسجة الجسم المختلفة.

ملحوظة:

• يضخ القلب حوالي 5 لترات/دقيقة.

• ينبض القلب حوالي 70 - 100 نبضة في الدقيقة.

الأسباب:

- 1- ارتفاع ضغط الدم.
- 2- انسداد الشرايين التاجية الرئيسية.
- 3- تليف عضلة القلب (اعتلال عضلة القلب).
- 4- تضيق أو قلس في الصمامات الرئيسية مثل الصمام التاجي أو الأبهر.

الأعراض:

- 1- ضيق التنفس وصعوبة التنفس أثناء ممارسة الرياضة.
- 2- نوبات ضيق في التنفس أثناء النوم مصحوبة بالتعرق الغزير وزرقة في الفم.
- 3- الوجه والبلغم مع الرغوة والدم.
- 3- السعال المتكرر.
- 4- تورم القدمين (الوذمة).
- 5- تضخم الكبد وألم البطن.

التشخيص:

- 1- الأشعة السينية للصدر.
- 2- تخطيط القلب.
- 3- تخطيط صدى القلب (الموجات فوق الصوتية للقلب).

العلاج:

- 1- علاج أسباب مثل ارتفاع ضغط الدم - تضيق الشرايين - تمدد الصمام.
- 2- الراحة الكاملة في السرير في وضعية شبه الجلوس.
- 3- إعطاء الأكسجين المرطب.
- 4- إعطاء مدرات البول، مثل لاسيكس - ألداكسون.

5- أقراص الديجوكسين (لأنوكسين).

6- حقن الأمينوفيلين في الوريد ببطء.

7- تقليل الملح في الطعام.

الإنعاش القلبي الرئوي CPR

أسباب السكتة القلبية المفاجئة:

- تؤدي السكتة القلبية المفاجئة إلى انخفاض الدورة الدموية وتوقف التنفس، مما يسبب فقدان الوعي. وإذا استمر لأكثر من 5 دقائق، فإنه يسبب ضررا دائما لخلايا الدماغ.
- يجب إجراء الإسعافات الأولية بسرعة وسهولة لتجنب المضاعفات.

أسباب السكتة القلبية:

- 1- قصور الشريان التاجي - ارتفاع ضغط الدم - اضطراب الصمام التاجي أو الأبهري.
- 2- الصدمات الكهربائية - الغرق - الاختناق.
- 3- جرعات المخدرات مثل المورفين - الكوكايين - الهيروين.
- 4- أثناء العمليات الجراحية وعند إعطاء التخدير.
- 5- الحوادث.

ما هي علامات السكتة القلبية والتنفسية:

- 1- فقدان الوعي.
- 2- غياب النبض - انخفاض ضغط الدم.
- 3- توقف التنفس
- 4- تغير لون الوجه.
- 5- اتساع حدقة العين.

الخطوات الرئيسية للإنعاش القلبي الرئوي:

- 1- توضع الضحية على ظهرها، ويفضل أن يكون ذلك بسطح صلب خلف ظهرها.
- 2- يتم إدخال قنية وريدية.
- 3- يتم وضع جهاز مجرى الهواء (المجرى الهوائي الحنجري) في الفم لضمان وصول الهواء إلى الرئتين.

4- يتم التنفس الاصطناعي عن طريق الفم أو باستخدام كيس أمبو.

5- يتم إجراء تدليك القلب بمعدل 4 ضغطات قلبية لكل نفس واحد.

6- إذا كان ذلك ممكناً، قم بتوصيل المريض بجهاز المراقبة.

7- الأدوية المطلوب توفرها أثناء الإنعاش هي:

أمبولة الأدرينالين - أمبولة زيلوكائين (ليدوكائين).

أمبولة الأتروبين.

أمبولة الكالسيوم.

محلول الجلوكوز: 5%.

محلول بيكربونات الصوديوم.

البيان على التليجرام

الفصل الثاني

أمراض الصدر

الربو القصبي

تعريف:

نوبات صعوبة في التنفس ناتجة عن تضيق متكرر في القصبات الهوائية ووجودها من الإفرازات اللزجة فيها.

الأسباب:

يمكن أن يحدث الربو القصبي في أي عمر:

1. الحساسية: تحدث النوبات عند التعرض لمسببات الحساسية أو الأبخرة مثل غبار المنزل وريش الطيور، الحيوانات، الفطريات في الهواء، حبوب اللقاح في الربيع.
كما أن بعض الأطعمة مثل الأسماك أو الحليب أو البيض أو الشوكولاتة أو بعض المضافات الغذائية مثل معززات النكهة مواد حافظة.
2. الحساسية لبعض الأدوية مثل الأسبرين ومشتقاته - مسكنات الألم.
3. الحساسية عند الأطفال بسبب ممارسة الرياضة.
4. هناك نوع من الربو القصبي يحدث عند البالغين ويعتبر سببه غير معروف.

الأعراض:

1. ضيق في الصدر - صعوبة في التنفس.
2. صوت الصفير أثناء الاستنشاق والزفير.
3. التعرق الشديد - والإرهاق في الحالات الشديدة.
4. السعال مع البلغم.
5. زرقة الوجه والكفين - انخفاض ضغط الدم - زيادة النبض.
6. يستمر الهجوم من ساعات إلى أيام.

التشخيص:

1. الأشعة السينية للصدر.
2. اختبارات وظائف الرئة.
3. غازات الدم ABG.
4. صورة الدم كاملة.

العلاج:

- 1- يتم إعطاء موسعات الشعب الهوائية عن طريق جهاز الاستنشاق أو البخاخات (مثل فينتولين - أتروفنت...).
- 2- يتم إنشاء خط وريدي بمحلول ملحي + يتم إعطاء موسعات الشعب الهوائية مثل الأمينوفيلين.
- 3- تعطى مستحضرات الكورتيكوستيرويد عن طريق الوريد في الحالات الشديدة.
- 4- تعطى حقن الأدرينالين (عند الأطفال ويحذر شديد) تحت الجلد.
- 5- يتم إعطاء المضادات الحيوية واسعة الطيف.
- 6- الأكسجين المرطب بمعدل 3-4 لتر/دقيقة.
- 7- العناية المركزة واستخدام جهاز التنفس الصناعي في حالات فشل الجهاز التنفسي.

السل الرئوي

تعريف:

ميكروب السل الرئوي (عصية السل) له نوعان ويسمى المتفطرة

مرض السل.

(أ) من البشر (الإنسان). (ب) من الماشية (الأبقار).

عوامل الإصابة بالسل (علم الأوبئة):

- 1- العمر: شائع في الفترة من 5 إلى 15 سنة. (لكنه يؤثر على جميع الأعمار).
- 2- يؤثر على الذكور والإناث.
- 3- الأماكن المزدحمة - ضيقة - ورطبة مع تهوية سيئة (مثل السجون - المدارس - الاتصال بالحيوانات في المزارع - المسالخ).
- 4- سوء التغذية - مرضى السكري - مرضى الإيدز - والسرطان.
- 5- اتصالات مرضى السل الرئوي.

أعراض مرض السل الرئوي:

1. ضعف عام - فقدان الوزن - فقدان الشهية - حمى - وتعرق غزير في الليل.
2. السعال الجاف ثم السعال مع البلغم وأحياناً البلغم الدموي.
3. صعوبة في التنفس.
4. ألم في الصدر.
5. انتشار المرض إلى أجزاء أخرى من الجسم مثل الأمعاء - القلب - الكلى - الدماغ - الجلد - الغدد الليمفاوية.

التشخيص:

1. الأشعة السينية للصدر.
2. تحليل البلغم لميكروب السل (3 مرات).
3. صورة الدم - ESR.
4. اختبار السلين تحت الجلد وقراءته بعد 72 ساعة.
5. الثقافة والحساسية لميكروب السل.
6. اختبار Bactec أو اختبار PCR.
7. مراقبة العلاج (ريفامبيسين) باستخدام وظائف الكبد ALT, AST.

علاج السل:

1. الراحة الكاملة في السرير.
2. الحفاظ على نظام غذائي صحي وتناول الفيتامينات مثل فيتامين ب6.
3. الإقلاع عن التدخين.
4. عزل المريض عندما يكون البلغم إيجابياً للبكتيريا (اعتبارها مصدراً للبكتيريا عدوى).
5. التحكم في مستوى السكر أو علاج الأمراض المصاحبة له.
6. العلاج الطبي على شكل أقراص: INH (إيزونيازيد) - إيثامبوتول - ريفامبيكان - حقنة الستربتوميسين - بيرازيناميد.
7. العلاج الطبي على شكل أقراص: INH (إيزونيازيد)، إيثامبوتول، ريماتان (ريفامبيسين)؛ الحقن: الستربتوميسين؛ والبيرازيناميد
8. يجب مراقبة المريض يومياً (أخذ العلامات الحيوية - وزن المريض - الشهية...).

الموضوع الثالث

الالتهاب الرئوي

تعريف

هو التهاب حاد يصيب فص أو أكثر من فصوص الرئة، ويحدث نتيجة استنشاق ميكروب المكورات الرئوية (المكورات الرئوية).

طرق العدوى:

- 1- من خلال الهواء الملوث بالبكتيريا.
- 2- من خلال الأدوات الملوثة (في المستشفيات) مثل أقنعة الأكسجين - أنابيب الحنجرة.

الأعراض:

- 1- الحمى المفاجئة - والقشعريرة.
- 2- زيادة النبض - وزيادة معدل التنفس (طبيعي 12-16 مرة/دقيقة).
- 3- ثم يصبح السعال الجاف مصحوباً ببلغم مخاطي ممزوج بالدم أحياناً.
- 4- الشعور بصعوبة في التنفس.
- 5- ألم حاد في جدار الصدر.

المضاعفات:

- 1- انتشار المرض بين الفصوص أو عبر الرئتين.
- 2- حدوث فشل في الجهاز التنفسي.
- 3- انتشار المرض إلى القلب - الكلى - المخ - المفاصل.
- 4- قصور القلب الحاد.

التشخيص:

- 1- الأشعة السينية للصدر.
- 2- صورة الدم - ESR.
- 3- تحليل البلغم للميكروبات العادية.

العلاج:

- 1- الراحة في الفراش.
- 2- إعطاء الأكسجين المرطب.
- 3- إعطاء خافضات الحرارة مثل الأسبرين - بارامول (الباراسيتامول).
- 4- المضادات الحيوية واسعة الطيف تعطى عن طريق الحقن الوريدي.
- 5- إعطاء السوائل الوريدية عند الضرورة.
- 6- علاج قصور القلب.
- 7- مراقبة العلامات الحيوية.

مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD)

وانتفاخ الرئة

الأسباب:

- 1- التدخين بكافة أشكاله مثل السجائر - السيجار - الشيشة (الشيشة) - وغيرها.
- 2- التعرض للدخان والغبار الملوث.
- 3- العدوى الميكروبية المصاحبة للمرض.

الأعراض:

- 1- السعال المستمر لعدة أشهر على الأقل كل عام لمدة سنتين متتاليتين.
- 2- يصاحب السعال بلغم لزج بكميات كبيرة وقد يحتوي على دم أو صديد.
- 3- الشعور بصعوبة في التنفس وأزيز في الصدر.
- 4- زرقة الجسم وخاصة الشفاه مع زيادة معدل التنفس.

التشخيص:

- 1- الأشعة السينية للصدر.
- 2- اختبارات وظائف الرئة.
- 3- إجراء غازات الدم.

العلاج:

- 1- الإقلاع التام عن التدخين.
- 2- تجنب الغبار والدخان الذي يلوث ويهيج الشعب الهوائية.
- 3- الأدوية المثبطة للسعال.
- 4- المضادات الحيوية واسعة الطيف.

5- الأكسجين المرطب (الكمية التي يحددها الطبيب)+ يتم إعطاء موسعات الشعب الهوائية عن طريق

بخاخات تشبه الاستنشاق (فيتولين - كلينيل).

6- أفراس أمينوفيلين لتوسيع الشعب الهوائية.

من قناة دمريضيانو على التليجرام

الجزء الثالث

نزيف الجهاز الهضمي

مقدمة:-

على الرغم من التقدم الحديث في تشخيص وعلاج حالات النزيف المعوي، إلا أنها لا تزال تمثل الحالات الأكثر شيوعاً التي يواجهها أطباء الطوارئ في المستشفيات. ويصل معدل الوفيات الناتجة عن النزيف المعوي إلى ما يقرب من 10%.

الأسباب:-

(1) أسباب نزيف الجهاز الهضمي العلوي.

- التهاب المريء، دوالي المريء.
- سرطان المريء.
- التهاب المعدة أو قرحة المعدة.
- التهاب الاثني عشر أو قرحة الاثني عشر.
- سرطان المعدة.

(ب) أسباب نزيف الجهاز الهضمي السفلي.

- التهاب القولون أو التهاب القولون التقرحي.
- خلل التنسج الوعائي.
- البواسير.
- سلائل القولون.
- التهاب الرتج.
- التهاب القولون الإقفاري.
- سرطان القولون.

الأعراض:-

مرضى يعاني من نزيف حاد في الجهاز الهضمي يشكو من الشعور (الدوخة - الضعف - زيادة معدل ضربات القلب - التعرق - صعوبة التنفس).

➤ يظهر النزيف بأحد الأشكال الثلاثة التالية:-

(أ) قيء الدم (قيء الدم)

يتقيأ المريض دمًا أو مادة تشبه القهوة المطحونة ومصدر قيء الدم هو الجهاز الهضمي العلوي.

(ب) براز أسود قطراني (ميلينا)

مصدره هو الجهاز الهضمي العلوي، والأمعاء الدقيقة، وحتى منتصف القولون المستعرض. هو الدم الذي أصبح أسود اللون نتيجة عمل حمض المعدة في المعدة أو تأثير البكتيريا في حالة القولون.

(ج) نزيف المستقيم (تغوط دموي):

مصدره عادة هو الجهاز الهضمي السفلي، وأحياناً عندما يكون النزيف شديداً من الجهاز الهضمي العلوي.

التشخيص :-

1- الفحص السريري للمريض :-

(قياس ضغط الدم والنبض ودرجة الحرارة)

2- سحب الدم وأدائه:-

- تعداد الدم الكامل (CBC).
- فصيلة الدم والتطابق.
- وظائف الكلى (نيتروجين اليوريا في الدم (BUN) والكرياتينين).
- اختبارات وظائف الكبد، إنزيمات الكبد (SGOT، SGPT)، ألبومين المصل.
- زمن البروثرومبين (PT).
- إلكتروليات المصل.

العلاج :-

1- استعادة أو استبدال الدم المفقود على النحو التالي:-

- تركيب قسطنطين وريدتين كبيرتين.
 - إعطاء المريض محلول ملحي متساوي التوتر.
 - إعطاء المريض خلايا الدم الحمراء المعبأة.
 - إعطاء مريض التليف الكبد (البلازما الطازجة المجمدة - الصفائح الدموية).
- ### 2- معالجة السبب.

نزيف حاد في الجهاز الهضمي

طبيعة النزيف

براز دموي

إدخال أنبوب رايل

(إي جي دي)

قيء دموي ميلينا

تنظير الجهاز الهضمي العلوي

تنظير المريء والمعدة والاثنى عشر

(إي جي دي)

علاج السبب

س مصدر

تم تحديد النزيف لم يتم التعرف عليه

علاج السبب تنظير القولون

مصدر النزيف غيابه وجود الدم أو الصفراء الدم أو الصفراء

(إي جي دي)

لم يتم تحديد مصدر النزيف

مصدر النزيف

س مصدر

تم تحديد النزيف لم يتم التعرف عليه

الفحص الشعاعي للأمعاء الدقيقة

علاج السبب

(متابعة الباريوم)

قرحة هضمية

قرحة المعدة والاثني عشر هي أحد الأمراض العنيدة سريراً والتي تتميز بضعف الغشاء المخاطي المبطن لجدار المعدة والاثني عشر. في الماضي، كان الأطباء يعزون السبب إلى زيادة إفراز حمض المعدة في المعدة وكذلك زيادة إفراز الببسين، ومن هنا جاء المثل الشهير "لا حمض، لا قرحة" (لا قرحة بدون حمض).

الأسباب المؤدية إلى تكوّن القرحة:-

- بكتيريا هليكوباكتر بيلوري.
- استخدام مسكنات الألم والأدوية المضادة للروماتيزم (مضادات الروماتيزم).
- متلازمة زولينجر إليسون.
- التهابات الفيروسية.
- الإشعاع أو العلاج الكيميائي.
- الكحول والأطعمة الحارة.
- التوتر العصبي وطبيعة العمل.

➤ دور بكتيريا هليكوباكتر في تكوين قرحة المعدة والاثني عشر.

تحدث العدوى نتيجة تلوث الطعام والشراب بالنفايات البرازية.
انتشار هليكوباكتر بيلوري في جدار المعدة.

العدوى البكتيرية المزمنة لجدار المعدة

السموم البكتيرية (Cag-A - Vac A)

زيادة شدة الالتهاب.

قرحة المعدة

التدخين - العمر وقت الإصابة بالبكتيريا الحلزونية هيليكوباكتر



الأعراض :-

1- آلام البطن التي يخففها الطعام في حالة قرحة الاثني عشر وتزداد في حالة قرحة المعدة. 2- فقر الدم غير الملحوظ بسبب النزيف الناتج عن القرحة ونقص الحديد. 3- الغثيان أو القيء.

4- فقدان الشهية وفقدان الوزن.

المضاعفات :-

- 1- قيء الدم.
- 2- انسداد فتحة البواب بين المعدة والاثني عشر.
- 3- ثقب القرحة

التشخيص :-

تشخيص القرحة:

- 1- تنظير الألياف البصرية للجهاز الهضمي العلوي.
- لتشخيص عدوى هليكوباكتر بيلوري:
- 1- قياس مستوى الأجسام المضادة للبكتيريا في الدم.
- 2- أخذ عينة من القرحة عن طريق التنظير وفحصها تحت المجهر.
- 3- اختبار تنفس اليوريا.
- 4- اختبار مستضد البراز.

العلاج:

- 1- طعام سهل الهضم خالي من البهارات.
 - 2- تجنب التدخين والكحول.
 - 3- الأدوية التي تمنع إفراز الحمض قبل الوجبات (مثبطات مضخة البروتون). مثال: لانسوبرازول 30 ملغ.
- علاج هليكوباكتر بيلوري لمدة 14 يوماً:**
- 1- لانسوبرازول 30 ملغ مرتين يومياً.
 - 2- أموكسيسيلين 1 جرام مرتين يومياً.
 - 3- كلاريثروميسين 500 ملغ مرتين يومياً.

الإسهال الحاد

الأسباب

1- الميكروبات الغازية والمدمرة التي تؤثر على جدار القولون.

- شيجيلا
- السالمونيلا
- كامبيلوباكتري جيجوني
- الأميبا الهستوليتيكا

2- الميكروبات غير الغازية (تفرز السموم)

- الكوليرا (ضمة الكوليرا)
- كولي

الإسهال الحاد



حمى
الزحار (براز مصحوب بالدم أو المخاط) (الزحار)
ألم البطن



فحص البراز



الأميبا



علاج الطفيليات



وجود الدم أو خلايا الدم البيضاء في البراز وجود الطفيليات/



العلاج: - الشيجيلا
- السالمونيلا
- كامبيلوباكتري (علاج
مسببات الأمراض)

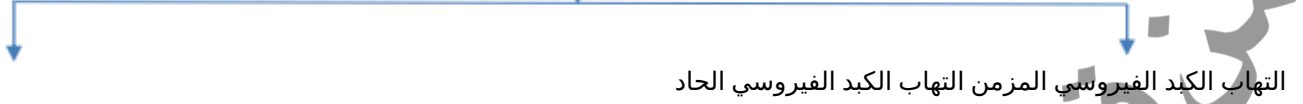
العلاج:

1- تعويض السوائل المفقودة.

2- بالنسبة للشيجيلا: قرص سيبروفلوكساسين 500 ملغ مرتين يومياً لمدة 5 أيام.

3- بالنسبة للأميبا: ميترونيدازول 750 ملغ كل 8 ساعات لمدة 5 أيام.

الموضوع الرابع التهاب الكبد الفيروسي



التهاب الكبد الفيروسي الحاد

الأسباب:-

تحدث العدوى بسبب الإصابة بأحد فيروسات التهاب الكبد. وأشهرها:-

• هافر فور د

• فيروس التهاب الكبد
ب

• HDV

• فيروس التهاب الكبد
الوبائي سي

• فيروس التهاب الكبد
الوبائي

ح: التهاب الكبد
الخامس: فيروس

الأعراض:-

- 1- أعراض التهاب الكبد الفيروسي الحاد تشبه أعراض الأنفلونزا مثل الشعور بالتعب الشديد والحمى الخفيفة وآلام العضلات والمفاصل.
- 2- تكون هذه الأعراض مصحوبة بالغثيان أو القيء المتكرر.
- 3- بعد ذلك يظهر اصفرار العينين (الصلبة) وأحياناً الجلد أيضاً (اليرقان) وقد يلاحظ المريض أو من حوله هذا الاصفرار، كما يمكن ملاحظة تغير في لون البول (مثل الشاي).
- 4- تستمر أعراض التهاب الكبد الحاد حوالي 4-6 أسابيع.
- 5- لا تختلف هذه الأعراض حسب نوع الفيروس، لكن شدة ظهورها تختلف حسب عمر المريض وأيضاً حسب نوع الفيروس.

(أ) على سبيل المثال، في حالة الإصابة بفيروس التهاب الكبد الوبائي، تكون الأعراض خفيفة عند الأطفال وقد تقتصر فقط على عدم الراحة والغثيان في الجهاز الهضمي، ولكن عند البالغين تكون الأعراض أكثر شدة ووضوحاً.

(ب) في حالة الإصابة بفيروس التهاب الكبد الوبائي سي، لا تظهر أي أعراض في أغلب الحالات ولا يشكو المريض من أي شيء.

(ج) في بعض الأحيان مع الإصابة بفيروس التهاب الكبد الوبائي، بعد أن يشعر المريض بالتحسن، يظهر اليرقان مرة أخرى (التهاب الكبد الانتكاسي) ويحدث هذا الانتكاس خلال شهرين من بدء العدوى الفيروسية.

طرق الإرسال:-

طريقة	أ	هـ	ب	د	ج
الأغذية الملوثة	✓	✓	-	-	-
مشروب ملوث	✓	✓	-	-	-
بين أفراد الأسرة	-	-	✓	✓	✓
عصي الإبرة	-	-	✓	✓	✓
مدمنو المخدرات	-	-	✓	✓	✓
نقل الدم	؟	؟	✓	✓	✓
غسيل الكلى	-	-	✓	✓	✓
عن طريق الجنس	-	-	✓	✓	✓
من الأم الحامل إلى الطفل	-	-	✓	✓	✓

إذا تم نقل الدم الذي يحمل فيروس HEV أو HAV من مريض بدون أعراض خلال فترة حضانة الفيروس، فإن العدوى تنتقل عن طريق الدم.

التهاب الكبد الفيروسي (أ) التهاب الكبد الحاد (أ)

تنتقل عدوى فيروس التهاب الكبد الوبائي من المريض إلى الشخص السليم عن طريق تناول وشرب المياه الملوثة ببراز المريض وبوله.

- في المناطق غير الحضرية (انخفاض الحالة الصحية) وبسبب التلوث البيئي، معدل الإصابة بفيروس التهاب الكبد الوبائي أعلى مما هي عليه في المناطق الحضرية.
- في المناطق غير الحضرية، يصيب فيروس التهاب الكبد الوبائي الأطفال في السنوات الأولى من حياتهم، وتكون العدوى في معظم الحالات أعراض خفيفة ويتم تشخيص إصابة الطفل التهاب المعدة والأمعاء الفيروسي الحاد.
- في المناطق الحضرية، يصيب فيروس التهاب الكبد الوبائي الأطفال الأكبر سنًا والبالغين وتكون الأعراض واضحة وكاملة.
- وفي جميع الحالات يكتسب المريض مناعة مدى الحياة "مدى الحياة" ضد فيروس التهاب الكبد الوبائي ولا يصاب بالعدوى مرة أخرى.

المضاعفات :-

في نسبة صغيرة جدًا، قد يؤدي التهاب الكبد الحاد (أ) إلى فشل الكبد الحاد والغيوبة.
• لا يؤدي التهاب الكبد الحاد (أ) أبدًا إلى التهاب الكبد المزمن.

التهاب الكبد الفيروسي (ب) التهاب الكبد الحاد (ب)

تنتقل العدوى بهذا الفيروس من حاملي الفيروس إلى الأفراد الأصحاء عن طريق نقل الدم ومنتجات الدم

- يصيب هذا الفيروس الأطفال والبالغين.
- يصاب الأطفال بالفيروس من أمهات يحملن الفيروس (الانتقال العمودي)، بينما تنتقل العدوى لدى البالغين من خلال طرق أخرى مثل الأدوات الجراحية الملوثة - الوشم - إبر الوخز بالإبر - المخدرات المحقونة - العلاقات الجنسية - المناظير الملوثة - أجهزة غسيل الكلى الملوثة.

المضاعفات

- وتكمن خطورة هذا الفيروس في قدرته على نقل المريض من مرحلة التهاب الكبد الحاد إلى التهاب الكبد المزمن، مما يؤدي إلى تليف الكبد وأورام الكبد.
- ومعدل هذا التحول مرتفع عند الأطفال (حوالي 90%) وعند البالغين حوالي 10%.

التهاب الكبد الفيروسي الحاد (د) التهاب الكبد الحاد (د)

تحدث العدوى بفيروس HDV فقط في المرضى المصابين بفيروس التهاب الكبد B. قد تكون العدوى متزامنة مع فيروس التهاب الكبد B، والمريض في هذه الحالة مصاب بالتهاب الكبد الحاد الناجم عن كلا الفيروسين، أو قد تكون العدوى متسلسلة، أولاً: فيروس التهاب الكبد B ثم فيروس HDV (عدوى إضافية) والمريض في هذه الحالة مصاب بالتهاب الكبد المزمن الناجم عن التهاب الكبد المزمن B ثم يصاب بفيروس HDV مما يسبب توهجاً حاداً لالتهاب الكبد الحاد D (الحاد D فوق المزمن B).
- يشبه فيروس HDV فيروس التهاب الكبد B في طرق انتقاله وتطور المرض ومضاعفاته.

التهاب الكبد الفيروسي الحاد (ج) التهاب الكبد الحاد (ج)

- ينتقل فيروس التهاب الكبد الوبائي من المرضى إلى المصابين عن طريق الدم الملوث ومنتجاته، على غرار فيروس التهاب الكبد الوبائي في هذا الصدد، لكنه نادراً ما ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي أو من الأم إلى طفلها حديث الولادة.
- تعتبر مصر من الدول التي لديها أعلى معدلات الإصابة بفيروس التهاب الكبد الوبائي في العالم.
- تكمن خطورة هذا الفيروس في أن 50% من المصابين به يصابون بالتهاب الكبد المزمن، مما يؤدي إلى لتليف الكبد والأورام.

التهاب الكبد الفيروسي الحاد (E) التهاب الكبد الحاد (E)

تشبه العدوى بفيروس التهاب الكبد الوبائي فيروس التهاب الكبد الوبائي من حيث طرق انتقال العدوى وعدم قدرته على التسبب بأمراض الكبد المزمنة، ولكن إذا أصيبت به المرأة الحامل فإنه يحمل خطر الإصابة بفشل الكبد الحاد.

طرق التشخيص



(1) اختبارات وظائف الكبد اختبارات وظائف الكبد (ل. ف. ت.)

(أ) إنزيمات الكبد:-

ترتفع إنزيمات الكبد بشكل ملحوظ في التهاب الكبد الحاد، وربما تصل إلى عشرة أضعاف أو أكثر.

• بديل

• أست

• ألك.ف (الفوسفاتيز القلوي)

• جي جي تي (جاما غلوتاميل ترانسفيراز)

(ب) مستوى البيليروبين:-

يرتفع مستوى البيليروبين في دم المريض إلى أكثر من 1 ملغم/ديسيلتر وأكثر.

(ج) زمن البروثرومبين:-

س. الزلال

ولا تتأثر هذه الحالات إلا في الحالات الشديدة ومع حدوث فشل كبدي حاد.

(2) التحقيقات للكشف عن الفيروسات

(أ) لالتهاب الكبد الحاد (أ)

• الأجسام المضادة لـ HAV _

• هناك نوعان:

• مضاد HAV _ IgM ..وهي موجودة مع عدوى حادة وتختفي مع تعافي المريض.

• مضاد HAV _ IgG ..وتظهر بعد اختفاء النوع الأول وتستمر مدى الحياة، مما يدل على الإصابة السابقة بهذا الفيروس.

(ب) لالتهاب الكبد الحاد (ب)

• المستند السطحي للفيروس - HBs Ag.

- يشير وجوده إلى أن المريض يعاني من عدوى حادة أو عدوى مزمنة (التهاب الكبد المزمن ب) أو (التهاب الكبد الحاد ب).

- الأجسام المضادة للمستند السطحي للفيروس (الأجسام المضادة لـ HBs).

تظهر هذه الأجسام المضادة في وقت اختفاء HBs Ag لدى المريض المصاب بالتهاب الكبد B الحاد. وهذا يعني تطور المناعة وتعافي المريض.

- HBe Ag - يشير إلى أن المريض هو مصدر قوي للعدوى

- الأجسام المضادة لـ HBe - تشير إلى أن المريض ليس مصدرًا للعدوى.

- مضاد HBe Ag - موجود في حالة التهاب الكبد الحاد.

- مضاد HBe Ag - يظهر مع اختفاء IgM ويشير إلى نهاية مرحلة التهاب الكبد الحاد، أو قد يعني فقط أن المريض قد أصيب بعدوى سابقة بفيروس التهاب الكبد B، أو قد يعني وجود التهاب الكبد المزمن إذا كان مصحوبًا مع استمرار وجود HBs Ag.

• هناك أيضًا اختبار PCR الذي يكتشف وجود الفيروس نفسه.

(ج) لالتهاب الكبد الحاد (ج)

• نستنتج وجود فيروس التهاب الكبد الوبائي سي في المريض المصاب بالتهاب الكبد الحاد من خلال اختبار PCR الذي يكشف عن وجود الفيروس نفسه.

• أما بالنسبة للأجسام المضادة لفيروس التهاب الكبد الوبائي، فهي تظهر متأخرة بعد 3-5 أسابيع من وقت الإصابة الحادة.

(د) لالتهاب الكبد الحاد (د)

• مضاد HDV IgM - يشير إلى وجود عدوى حادة في الكبد.

• مضاد HDV IgG - يشير إلى وجود عدوى مزمنة في الكبد.

(هـ) لالتهاب الكبد الحاد (هـ)

• مضاد HEV IgM - يشير إلى وجود عدوى حادة في الكبد.

• مضاد HEV IgG - يشير إلى أن المريض كان يعاني من عدوى سابقة بفيروس HEV.

طرق الوقاية من التهاب الكبد الفيروسي

1- تطعيم الأطفال والبالغين ضد التهاب الكبد (أ، ب). 2- الاهتمام بالنظافة الشخصية. 3- الاهتمام بالنظافة العامة.

4- عدم استخدام الأغراض الشخصية للآخرين مثل المقص وشفرات الحلاقة وفرشاة الشعر وفرشاة الأسنان.

5- التأكد من تعقيم الأدوات الجراحية والمناظير.

❖ العلاج:

أ	غير ضروري
ب	IFN - لام .. أدف
د	IFN - لام .. أدف
ج	IFN - .. ضلع
هـ	غير ضروري

• IFN = إنترفيرون

• لام = لاميفودين

• RIB = ريبافيرين

• ADV = أديفوفير

من واحة الدكتور رضوان على التليجرام

التهاب الكبد الفيروسي المزمن

- إذا استمر التهاب الكبد الحاد لأكثر من 6 أشهر، يدخل المريض في مرحلة التهاب الكبد المزمن.
- يحدث هذا للمصابين بفيروس التهاب الكبد (ب) و (ج).

الأعراض :-

- 1- الشعور بالتعب المستمر.
- 2- ملاحظة اصفرار العينين (اليرقان) والذي قد يصاحبه تغير في لون البول أحياناً.
- 3- قد يشعر المريض بزيادة في حجم البطن بسبب تضخم الكبد والطحال.
- 4- في كثير من الأحيان لا يشكو المريض من أي شيء على الإطلاق، ولا يتم اكتشاف المرض إلا عند إجراء الاختبارات الفيروسية للسفر أو عند الخضوع لعملية جراحية.

المضاعفات :-

- 1- حدوث تليف الكبد مع زيادة ضغط الوريد البابي (ارتفاع ضغط الدم البابي) وظهور الدوالي (دوالي المريء) والاستسقاء البطني.
- 2- مع تدهور وظائف الكبد يصبح المريض عرضة للغيوبة الكبدية. 3- حدوث أورام الكبد.

طرق التشخيص :-

- 1- وظائف الكبد: - ارتفاع إنزيمات الكبد.
- ارتفاع مستوى البيليروبين.
- انخفاض الألبومين.
- 2- إطالة زمن البروثرومين.

التحقيقات الفيروسية :-

أ) في حالة التهاب الكبد المزمن (ب) (CHB):
• HBs Ag، مضاد HBc IgG، PCR.

ب) في حالة التهاب الكبد المزمن (ج) (CHC):
• مضاد لفيروس التهاب الكبد الوبائي سي، تفاعل البوليميراز المتسلسل.

3- الموجات فوق الصوتية على البطن:

يكتشف وجود تضخم الطحال والكبد، ويكتشف وجود تليف الكبد وارتفاع الوريد البابي. الضغط، ويستخدم لتشخيص وجود الاستسقاء وأورام الكبد.

العلاج:

- دواء إنترفيرون ألفا أو لاميفودين أو أديفوفير لعلاج CHB.
- دواء إنترفيرون ألفا وريبافيرين لعلاج CHC.

داء البلهارسيا أو البلهارسيا

- ينتشر داء البلهارسيا على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم، وخاصة في أفريقيا وأمريكا الجنوبية والعديد من البلدان في آسيا.

- تم تسمية داء البلهارسيا على اسم الطبيب الألماني ثيودور بلهارس الذي اكتشف الدودة في عام 1851 م.

- تحدث العدوى البشرية بعد ملامسة إحدى مراحل طفيل البلهارسيا (مرحلة السركاريا) عند السباحة في المياه العذبة.

- هذه المرحلة من طفيل البلهارسيا (Cercaria)، عندما يتلامس مع جلد الإنسان، يخترقه ثم ينتقل إلى الأوعية الدموية في المثانة البولية (في حالة S. haematobium) أو الأوعية المسارية (في حالة S. mansoni). مانسوني).

- بعد فترة يتحول السركاريا إلى دودة كاملة تضع بيضًا ينتقل مع الدم ويتركه، ويخترق الأنسجة مسببًا التهاب ومن ثم التليف في الأنسجة المضابة.

أعراض داء البلهارسيا:

1- في حالة (S. haematobium) (عدوى المسالك البولية):

• البول الدموي – التهابات المسالك البولية – حصوات المثانة والحالب – استسقاء الكلية والفشل الكلوي – وقد يتطور إلى أورام خبيثة في المثانة والحالب. 2- في حالة (S. mansoni) (عدوى معوية وكبدية):

• الإسهال والدم في البراز – فقر الدم – تليف الكبد – تضخم الطحال – ارتفاع ضغط الوريد البابي – دوالي المريء – نزيف دوالي المريء.

التشخيص:

1- تحليل البول (متكرر) .. البيض. 2-

تحليل البراز (متكرر) .. البيض.

3- قص المستقيم بالفحص المجهرى .. البيض.

4- الأجسام المضادة ضد البلهارسيا في الدم (الأجسام المضادة للبلهارسيا). 5- وجود

بيض البلهارسيا في مجرى الدم

العلاج: برازيكوانتيل.

أسسديتيس

• تعريف:

هو تراكم السوائل المصلية في التجويف البريتوني للبطن، مما يؤدي إلى زيادة حجم البطن.

• الأسباب:

1- قصور القلب الحاد والمزمن. 2-

الفشل الكلوي. 3- فشل الكبد

4- (سل) مرض السل

5- النقائل البريتونية الثانوية للأورام الخبيثة.

الاستسقاء التليفي

❖ الاستسقاء هو أحد مظاهر تدهور وظائف الكبد لدى المرضى الذين يعانون من تليف الكبد.
❖ أعراضه:

- 1- زيادة مطردة في حجم البطن.
- 2- قد يكون مصحوبًا بتورم في القدمين.
- 3- يشكو المريض من التعب وصعوبة التنفس بسبب الضغط البطني على الحجاب الحاجز.
- 4- يشكو المريض من فقدان الشهية والشبع المبكر مع الشعور بالامتلاء وعسر الهضم.
- 5- بروز السرة إلى الخارج وفي الحالات الشديدة قد تتمزق مع تسرب السوائل مما يستلزم التدخل الجراحي.
- 6- احتقان وبرزوز أوردة جدار البطن، وتظهر على شكل أنابيب متعرجة عند فحص البطن.

❖ علاج:

- 1- منع الملح تمامًا من جميع أنواع الطعام. 2- استخدم مدرات البول.
- 3- راقب وزن المريض، حيث أن الاستجابة لمدرات البول معروفة من خلال الانخفاض المستمر في وزن المريض بالإضافة إلى اختفاء تورم القدم وانخفاض حجم البطن.

❖ المضاعفات:

- ❖ قد يؤدي وجود الاستسقاء في البطن إلى حالات مرضية خطيرة وهي:
- أو (1) التهاب الصفاق البكتيري العفوي.
 - أو (2) الاستسقاء المقاوم (وجود استسقاء لا يستجيب للعلاج). أو (3) المتلازمة الكبدية الكلوية (اضطراب في وظائف الكلى).

غيوبة الكبد (اعتلال الدماغ)

تعتبر الغيوبة الكبدية من أخطر مضاعفات تدهور وظائف الكبد وتنتج عن خلل في مراكز الدماغ العليا بسبب تدهور وظائف الكبد.

• تحدث غيوبة الكبد عند مرضى الكبد الذين يعانون من:

■ أو الفشل الكبدي الحاد

■ أو القصور الكبدي المزمن

(1) غيوبة الكبد في حالة الفشل الكبدي الحاد:-

• وهو نتيجة للتدهور السريع (الحاد) والشديد في وظائف الكبد.

• الأعراض :-

أو قد تسبق دخول المريض في الغيوبة حالة من الانفعال حيث يكون المريض عصبيًا جدًا وعرضة للعنف.

أو ويتبع ذلك دخول المريض في حالة تشبه النوم الطبيعي يستجيب خلالها المريض للمحفزات الخارجية.

أو مع مزيد من التدهور في وظائف الكبد، يدخل المريض في غيوبة كاملة ولا يفعل ذلك الاستجابة لأي محفزات خارجية.

• العلاج :-

أو يحتاج المريض إلى رعاية طبية مكثفة.

أو في بعض الحالات، قد يحتاج المريض إلى عملية زرع كبد من متبرع حي.

أو قد يحتاج بعض المرضى إلى إجراء مماثل لغسيل الكلى حيث يتم استخدام جهاز غسيل الكبد لأداء وظائف الكبد حتى يتحسن كبد المريض. يعتبر خط العلاج هذا مكلفًا وغير متاح على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم.

(2) غيوبة الكبد في حالة الفشل الكبدي المزمن:-

• وهو نتيجة للتدهور المستمر في وظائف الكبد، وقد تكون هناك عوامل خارجية تساهم في حدوثه، وهي:

1- الأمراض المعدية في الجهاز التنفسي أو البولي أو البريتوني

غشاء البطن.

2- نزيف من دوالي المريء أو المعدة أو نزيف من قرحة المعدة.

3- الإفراط في استخدام مدرات البول.

4- التصريف المفرط للسائل البريتوني.

5- الإفراط في تناول البروتين.

6- الإمساك الشديد أو الإسهال.

7- استخدام الأدوية المهدئة والمنومة.

الأعراض:-

(أ) المرحلة الأولى (أو مرحلة ما قبل الغيوبة حيث لا يوجد اضطراب مصاحب في جسم المريض

مستوى الوعي): حيث يوجد:

- تغيرات في شخصية المريض (سهولة الانزعاج - العصبية - التصرف كالأطفال - شديدة السعادة أو الحزن الشديد - النسيان المتكرر).
- اضطرابات النوم عند المريض: (الأرق - النوم أثناء النهار وقلة النوم ليلاً).
- عند فحص المريض: (ارتعاش اليد - رائحة فم مميزة (Fetor Hepaticus) - تغير في صوت المريض مع الكلام البطيء).

(ب) مرحلة الغيبوبة (قد لا يتم الوصول إليها إذا استجاب المريض للعلاج في المرحلة السابقة مرحلة).

يحدث تدهور تدريجي في وعي المريض، بدءاً من فقدان المريض الإحساس المكان والزمان وعدم القدرة على التعرف على الأشخاص أو حتى التعرف على أنفسهم، تليها غيبوبة خفيفة يشبه النوم الطبيعي ثم الغيبوبة العميقة.

• العلاج: يبدأ في أي مرحلة من مراحل الغيبوبة ويتضمن:

- 1- منع البروتين الحيواني من النظام الغذائي للمريض.
- 2- التوقف عن تناول مدرات البول.
- 3- استخدام شراب اللاكتولوز.
- 4- إدارة النيومايسين.
- 5- إجراء الحقن الشرجية المتكررة مع ملاحظة لون البراز.
- 6- استخدام المضادات الحيوية.
- 7- إجراء تنظير داخلي للمريء والمعدة في حالة وجود دم في المعدة البراز أو الاشتباه في نزيف الدوالي، حيث يتم حقنها أو ربطها لإيقافها النزيف.
- 8- في حالات الغيبوبة الشديدة، يحتاج المريض إلى دخول العناية المركزة.
- 9- إذا تحسنت حالة المريض، فقد يتم تقييمه لإجراء عملية زرع كبد من شخص حي المتبرع.

الجزء الخامس

الجهاز البولي

يتكون الجهاز البولي من الكلى والحالبين والمثانة والإحليل. تحتوي الكلية على حوالي مليون وحدة من النيفرونات، تتكون كل منها من الكبيبات و الأنابيب.

1. وظائف الكلى:

- 1- الحفاظ على التوازن بين كمية السوائل والأملاح الموجودة في بلازما الدم داخل الجسم، وكذلك بين حموضة الدم وقلوبته.
- 2- التخلص من مخلفات استقلاب البروتين.
- 3- إفراز هرمون الإريثروبويتين وتنشيط فيتامين د.
- 4- تنظيم ضغط الدم.
- 5- المساعدة في الحفاظ على مستوى السكر في الدم (تكوين الجلوكوز).

❖ تشخيص أمراض الكلى:

1- تحليل البول:

• يتم أخذ عينة من البول من منتصف مجرى البول في الصباح الباكر. بول منتصف التيار (MSU).

• يتم فحص البول كيميائياً ومجهرياً:

أو يتراوح اللون الطبيعي للبول من الأصفر الشفاف إلى الأصفر الداكن، ويعتمد هذا التغيير على تركيز صبغة اليوروكروم في البول.

أو تتراوح الكمية الطبيعية للبول من 800 إلى 2500 سم³ يوميًا.

أ) تحليل البول الكيميائي:

- 1- يتم فحص البول كيميائياً باستخدام شرائط مشربة بأجهزة الكشف (مقياس العمق) لتقدير الرقم الهيدروجيني بروتينات الألبومين، الهيموجلوبين، الجلوكوز، الكيتونات.

(ب) فحص البول المجهرى:

نتائج الامتحانات	الأسباب
1- القوالب أو كتلة تتكون في تجويف الكلى.	
أ) قوالب خلايا الدم الحمراء.	- التهاب كبيبات الكلى
ب) قوالب خلايا الدم البيضاء.	- (التهاب الحويضة والكلية الحاد)
ج) القوالب الدهنية.	- المتلازمة الكلوية
د) القوالب الحبيبية.	- مرض كلوي / نسيجي غير محدد
2- الخلايا.	
أ) خلايا الدم الحمراء.	التهاب المسالك البولية
ب) خلايا الدم البيضاء.	التهاب المسالك البولية
ج) الخلايا الحمضية.	التهاب الكلية الخلالي
3- البلورات.	
أ) حمض البوليك.	النقرس - البول الحمضي
ب) فوسفات الكالسيوم	البول القلوي
ج) أكسالات الكالسيوم	البول الحمضي

2- اختبارات وظائف الكلى (اختبارات وظائف الكلى):

أ) الوظيفة الكلى (GFR): معدل الترشيح الكبيبي:

1. قياس مستوى الكرياتينين و نيتروجين اليوريا في الدم (BUN) في البلازما. الكرياتينين يتراوح المستوى من 0.8 - 1.3 مجم/100 مل في الرجال و 0.6 - 1.1 مجم/100 مل عند النساء.

والنسبة بين مستوى الكرياتينين و نيتروجين اليوريا في الدم (BUN) هي 1:10.

إذا وصل مستوى الكرياتينين إلى الحد الأعلى المقبول وهو 1.3 ملغم/ديسيلتر عند الرجال، فهذا يعني الخسارة 50% من وظيفة الكبيبات.

2- تصفية الكرياتينين:

يتم قياسه وفقًا للصيغة التالية:

تصفية الكرياتينين = (الكرياتينين في البول × حجم البول) / (مستوى الكرياتينين في البلازما)

$$\text{تصفية الكرياتينين} = \frac{U \times V}{P}$$

U = الكرياتينين في البول ملغم/مل.

V = حجم البول مل/دقيقة (حجم البول على مدار 24 ساعة/1440).

P = مستوى الكرياتينين في البلازما ملغم/مل. (المعدل الطبيعي هو 95-105 مل/دقيقة)

ب) الوظيفة الأنبوية:

1- الحفاظ على الثقل النوعي للبول الذي يتراوح بين 1015-1025.

2- موازنة كمية السوائل والأملاح والقلوية وحموضة الدم داخل الجسم.

3- درجة حموضة البول أقل من 5.3.

4- الإفراز الجزئي للصوديوم (Fe Na).

وهو الجزء الصغير من ملح الصوديوم الذي يتم ترشيحه بواسطة الكبيبات وإفرازه في البول.

يتم قياسه وفقًا للصيغة التالية:

$$\text{UNa/PNa (Pcr/Ucr) = (Fe Na)}$$

الصوديوم البولي (mEq/100 مل) الكرياتينين في الدم (ملغ/مل)

صوديوم المصل (mEq/100 مل) الكرياتينين البولي (ملغ/مل)

يستخدم هذا الاختبار للتمييز بين الفشل الكلوي الناتج عن فقدان كمية كبيرة من السوائل أو الدم (الفشل الكلوي المسبق)، والفشل الكلوي الناتج عن إصابة أنسجة الكلى حيث القيمة أقل من 1% في النوع الأول وأكثر من 1% في النوع الثاني.

5- إفراز أقل من 150 ملغ/يوم من البروتينات (بدون الألبومين) في البول عند الشخص الطبيعي.

• إذا كانت كمية الألبومين في البول تتراوح بين 30-300 ملغ/يوم، فهذا يشير إلى فقدان جزئي للألبومين، ولكن إذا تجاوزت الكمية 3.5 جرام/يوم، فهذا ما يسمى بالمتلازمة الكلوية (S الكلوية).

(ج) فحص المسالك البولية (أو الجهاز البولي):

• عن طريق الأشعة السينية العادية (PUT) أو التصوير الشعاعي المتباين (IVP)، والموجات فوق الصوتية، وكذلك الأشعة المقطعية

(د) فحص النظائر الكلوية:

(هـ) خزعة الكلى: أخذ عينة من الكلى.

التهاب الحويضة والكلية الحاد

صعود البكتيريا سلبية الجرام مثل الإشريكية القولونية، وكذلك البكتيريا إيجابية الجرام من الحالب إلى الكلى، تسبب عدوى بكتيرية في أنسجة الكلى.

• الأعراض:

- 1- ألم مفاجئ في أحد الخاضرتين أو كليتهما (ألم الخاصرة) يمتد إلى الحفرة الحرقفية أو منطقة فوق العانة.
- 2- ارتفاع حاد في درجات الحرارة يصل إلى 40 درجة مئوية.
- 3- قشعريرة - قيء.
- 4- الألم عند التبول.
- 5- كثرة التبول بكميات قليلة.

• الفحوصات (التشخيص):

- 1- تحليل البول كيميائياً ومجهرياً.
- 2- ثقافة البول وحساسيته.
- 3- تعداد الدم الكامل (CBC).
- 4- الموجات فوق الصوتية على البطن والحوض (التصوير بالموجات فوق الصوتية للحوض والبطن).

• العلاج:

- إعطاء المضادات الحيوية وفقاً لثقافة البول وحساسيته.
- إذا لم تتمكن من انتظار نتيجة الثقافة، يمكن تناول أقراص سيبروفلوكساسين 500 ملغ كل 12 ساعة لمدة أسبوع واحد يمكن استخدامها.

الفشل الكلوي المزمن

متلازمة اليوريمية

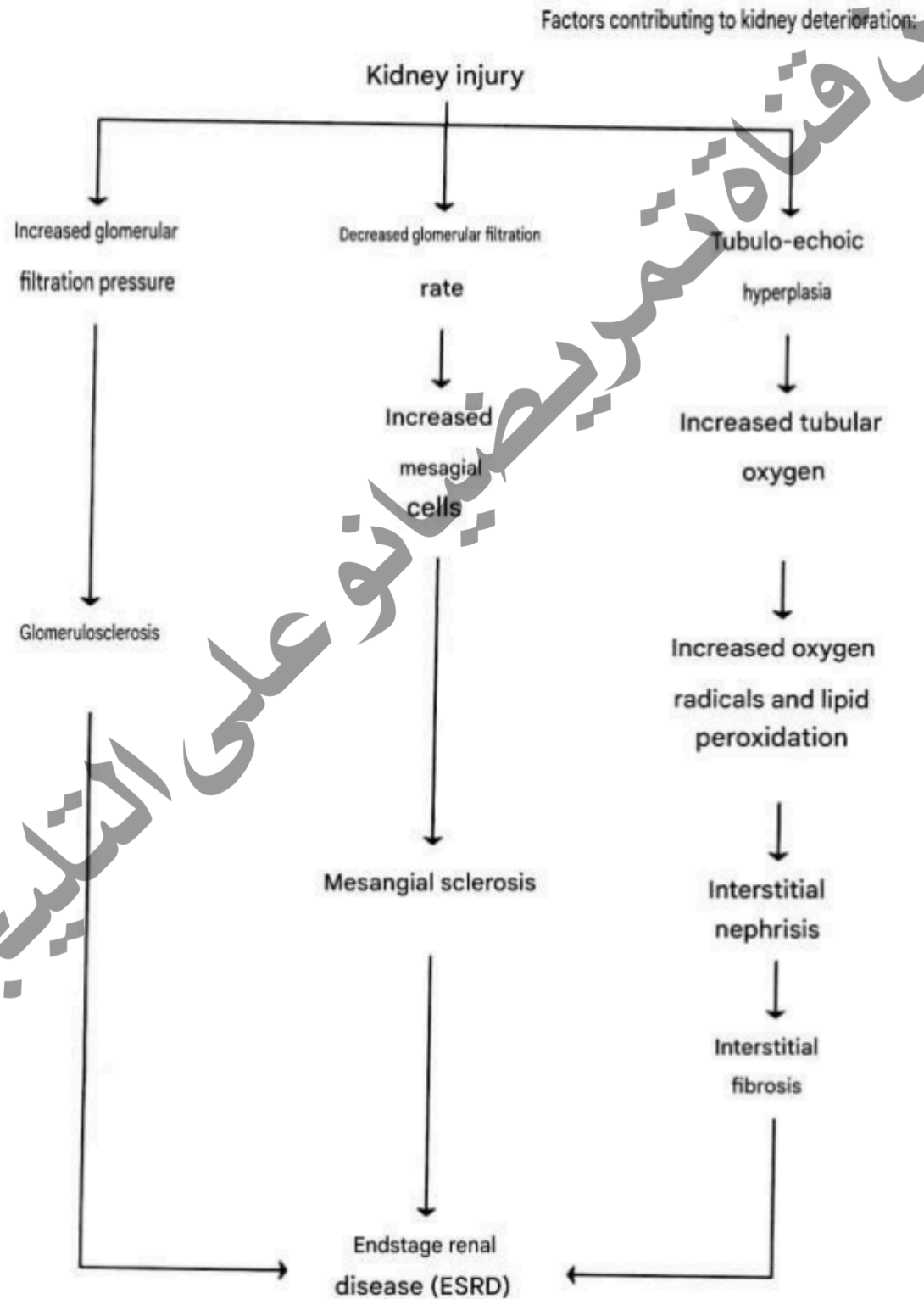
• تعريف:

الفشل الكلوي المزمن هو تدهور متقدم لا رجعة فيه في وظائف الكلى.

• الأسباب:

- أو مرض السكري (DM).
- أو ارتفاع ضغط الدم.
- أو التهاب كبيبات الكلى.
- أو الأمراض الوراثية التي تصيب الكلى مثل مرض الكلى المتعدد الكيسات.
- أو التهاب الكلية الخلالي والتهاب أنسجة الكلى المزمن (التهاب الحويضة والكلية المزمن).
- أو أمراض المناعة الذاتية التي تصيب الكلى مثل الذئبة الحمامية الجهازية (SLE).
- أو سبب غير معروف.
- أو انسداد المسالك البولية (حصوات - تضيق الحالب).

• العوامل التي تساعد على تدهور الكلى:-



• الأعراض:

1. الجهاز الهضمي

فقدان الشهية، الغثيان، القيء، قرحة المعدة، نزيف الجهاز الهضمي

2. جلد

حكة في الجلد، تغير لون الجلد إلى الأصفر

3. عضلات

ضعف العضلات، التقرن

4. الجهاز العصبي

التهيج، الأرق، فقدان الشهية، التشنجات، الغيبوبة

5. الأعصاب الطرفية

وخز وتنميل في اليدين والقدمين

6. دم

فقر الدم، النزيف، ضعف وظيفة خلايا الدم البيضاء.

7. نظام الغدد الصماء

انقطاع الطمث، زيادة نشاط الغدد جارات الدرق، مقاومة الأنسولين، زيادة الدهون في الدم مستويات.

8. الجهاز القلبي الوعائي والقلب

التهاب غلاف القلب، وزيادة قابلية الإصابة بتصلب الشرايين وضعف عضلة القلب.

9. الجهاز التنفسي

التهاب الجنب، الالتهاب الرئوي، الانصباب الرئوي

10. السوائل والإلكتروليتات

ارتفاع مستوى البوتاسيوم في الدم (فرط بوتاسيوم الدم)، زيادة حجم السوائل في الجسم، فرط فوسفات الدم، فرط مغنيزيوم الدم، عدم التوازن الحمضي القاعدي.

❖ التشخيص والعلاج :-

أ- يتم التشخيص كما تمت دراسته سابقاً:-

ب- تحديد العوامل التي يمكن علاجها مثل:-

1- ارتفاع مفاجئ في ضغط الدم.

2- عدوى المسالك البولية.

3- انسداد المسالك البولية.

4- فقدان الدم بسبب النزيف أو قصور القلب.

5- تسمم الدم.

6- الأدوية شديدة السمية للكلية مثل مضادات الروماتيزم.

7- النظام الغذائي: 40 جرام بروتين يومياً.

80 جرام كربوهيدرات.

90 جرام دهون.

8- تجنب الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم مثل الموز.

9- تصحيح نقص الإلكتروليت في الدم وتنظيم توازن السوائل.

10- العلاج ببدائل الكلية.

أ- غسيل الكلية عن طريق الناسور الشرياني الوريدي في الذراع، يتم إجراؤه لمدة 3-5 ساعات ثلاث مرات

أسبوعي.

ب- غسيل الكلية البريتوني المتنقل المستمر.

مناسب لمرضى السكري وكبار السن المصابين بأمراض القلب.

ج- زراعة الكلية.

الجزء السادس

أمراض الدم

تعريف:

الدم هو السائل الأحمر السميكة ويتكون من 90% ماء وخلايا الدم الحمراء (التي تنقل الأكسجين - ثاني أكسيد الكربون)، وخلايا الدم البيضاء (التي تدافع عن الجسم ضد الميكروبات)، والصفائح الدموية (المسؤول عن تخثر الدم).

جدول نطاقات تعداد الدم الكامل الطبيعي (CBC)

نسبة الهيموجلوبين	هـ ب	15 جرام %
عدد خلايا الدم الحمراء	كرات الدم الحمراء	5 مليون/مم ³
عدد خلايا الدم البيضاء	مجلس الملاكمة العالمي	11.000-4000/مم ³
عدد الصفائح الدموية	الصفائح الدموية	140.000-400.000/مم ³
عدد الخلايا الشبكية	الخلايا الشبكية	1 - 2%
ترسيب كريات الدم الحمراء	معدل ESR	5 - 20 ملم/ساعة

فقر الدم

التعريف :-

هو انخفاض في عدد خلايا الدم الحمراء أو انخفاض في الهيموجلوبين إلى ما دون المعدل الطبيعي.
(عدد خلايا الدم الحمراء 4.5 - 5.5 مليون لكل مليمتري مكعب)
(مستوى الهيموجلوبين 13-15 جرام / ديسيلتر)

❖ الأسباب:

1- نقص الحديد:

يؤدي نقص الحديد في النظام الغذائي (اللحوم - الكبد...) إلى ظهور أعراض فقر الدم.
وجود نزيف مستمر (مثل دوالي المريء - البواسير).
وجود الديدان الخطافية (الأنكلستوما).

2 - نقص حمض الفوليك أو فيتامين ب12.

يحدث عند النباتيين أو بسبب أمراض المعدة.

3- نقص فيتامين C أو E أو هرمون الغدة الدرقية.

4- إصابة نخاع العظم (بسبب سوء استخدام الأدوية أو الفيروسات المسببة للأمراض).

5- بعض الأمراض المزمنة مثل السل - السرطان - الفشل الكلوي - تليف الكبد.

6- التدمير المفرط لخلايا الدم الحمراء (انحلال الدم) في الأمراض الوراثية مثل الثلاسيميا -

فقر الدم المنجلي - فقر الدم الناجم عن نقص G6PD.

❖ أعراض فقر الدم:-

1- الشعور بالتعب عند بذل الحد الأدنى من الجهد.

2- ضعف الذاكرة.

3- الاكتئاب - فقدان الشهية.

4- الذبحة الصدرية - ألم في الصدر.

5- صعوبة التنفس.

6- زيادة معدل ضربات القلب (عدم انتظام دقات القلب).

7- شحوب الجلد والغشاء المخاطي للفم.

8- الدوخة - عدم وضوح الرؤية - الصداع المستمر.

❖ علاج فقر الدم

1- الراحة في الفراش.

2- العناية بالتغذية الجيدة عن طريق الفم.

3- إعطاء الفيتامينات - الحديد - البروتينات.

4- علاج أي مرض مصاحب لفقر الدم. 5- نقل الدم في الحالات الشديدة.

من فوائد دواء ريسبيديانوف على التليبيجرام

نقل الدم

❖ دواعي نقل الدم:-

- 1. فقر الدم الشديد.
- 2. سرطان الدم.
- 3. نزيف داخلي وخارجي.
- 4. مرضى الهيموفيليا.
- 5. حوادث - إصابات - حروق.

❖ مخاطر نقل الدم:-

- عدم توافق فصيلة الدم مما يؤدي إلى انحلال الدم الحاد.
- انتقال أمراض مثل فيروس التهاب الكبد الوبائي - فيروس التهاب الكبد الوبائي - فيروس نقص المناعة البشرية - الملاريا - الزهري.
- الحمى - الحساسية.
- قصور القلب - الوذمة الرئوية.
- انخفاض الكالسيوم وحدوث التشنجات.
- اختلال توازن مستويات البوتاسيوم والصوديوم مما يؤدي إلى عدم انتظام ضربات القلب.

❖ الاحتياطات والعلاج:-

- يجب التحقق بعناية من اسم المريض وكذلك فصيلة دم المريض وعامل Rh الموجود في الدم كيس.
- يجب تسخين الدم ببطء شديد قبل تناوله.
- احرص على عدم هز كيس الدم بقوة أثناء الحمل والنقل.
- يتم إعطاء أول 100 مل من الدم تحت المراقبة الدقيقة لأعراض مثل (ضيق التنفس - قشعريرة - آلام في البطن - طفح جلدي - بول أحمر).
- يجب إيقاف نقل الدم فورًا وإعطاء العلاج اللازم.

اللوكيميا

التعريف :-

سرطان الدم هو زيادة كبيرة في عدد خلايا الدم البيضاء بسبب تغير في نخاع العظم.

الأعراض :-

يحدث في أي عمر ولكن الأطفال عادة ما يتأثرون بسرطان الدم الليمفاوي الحاد ALL ويتأثر كبار السن بسرطان الدم المزمن سرطان الدم النقوي المزمن (CML) - سرطان الدم الليمفاوي المزمن (CLL).

الأعراض :-

- 1- حمى - التهاب الحلق - آلام في الجسم وآلام في العظام.
- 2- فقر الدم الشديد - التعب والإرهاق.
- 3- تضخم الكبد - الطحال - الغدد الليمفاوية.
- 4- نزيف في أجزاء مختلفة من الجسم مثل تحت الجلد - الأنف - اللثة..

تشخيص سرطان الدم :-

- 1- تظهر صورة الدم زيادة في خلايا الدم البيضاء وانخفاض في خلايا الدم الحمراء و الصفائح الدموية.
- 2- إجراء فحص نخاع العظم.
- 3- أخذ عينة من الكبد - الطحال - أو الغدد الليمفاوية.

علاج سرطان الدم :-

- 1- عزل المريض في غرفة مخصصة لذلك.
- 2- استخدام القفازات - الأقنعة - أغطية الرأس والقدم عند التعامل مع المريض لمنع انتقال العدوى
- عدوى إلى المريض.
- 3- نقل الدم أو بعض منتجاته.
- 4- إعطاء أدوية العلاج الكيميائي.
- 5- استخدام العلاج الإشعاعي العميق في بعض الحالات.
- 6- إجراء عملية زراعة نخاع العظم.

مبل النزيف

ويعتبر من أمراض الدم الخطيرة التي تؤدي إلى زيادة النزيف وفقر الدم.

الأسباب:

- 1- نقص الصفائح الدموية، ويحدث في حالات سرطان الدم وإصابة نخاع العظم.
- 2- نقص عوامل التخثر، ويحدث في بعض الأمراض الوراثية مثل الهيموفيليا - أمراض الكبد ونقص فيتامين ك.
- 3- بعض أمراض الأوعية الدموية.

الأعراض:

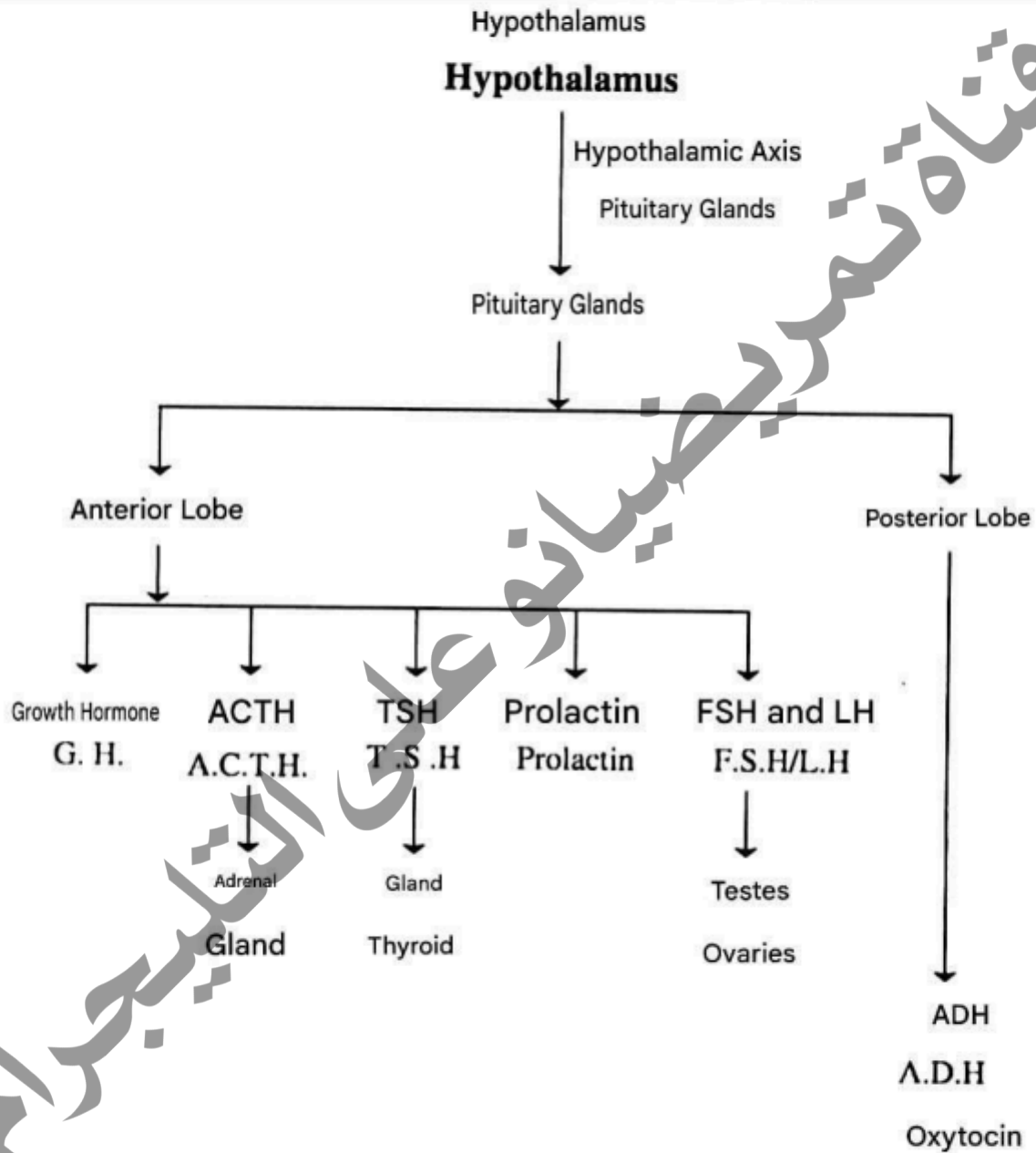
- 1- نزيف من الأنف - اللثة - قيء الدم - نزيف المستقيم - نزيف البول وغيرها.
- 2- نزيف تحت الجلد (كدمات).
- 3- نزيف داخلي مثل نزيف المخ - الأمعاء.

العلاج:

- 1- الراحة الكاملة.
- 2- نقل الدم أو نقل البلازما - أو نقل الصفائح الدموية.
- 3- فيتامين ك.
- 4- يمنع الحقن العضلي أو تحت الجلد، ويفضل الحقن في الوريد.

الجزء السابع

الغدد الصماء



الغدة الصماء:

يتحكم المهاد في معظم الغدد الصماء عن طريق إفراز الهرمونات التي تصل إلى الغدة النخامية الغدة عن طريق المحور (تحت المهاد - الغدة النخامية)، والتي تفرز بدورها الهرمونات لتحفيز وظيفة الغدة الدرقية والغدة الكظرية والغدة التناسلية (الخصيتين عند الذكور والمبيضين عند الإناث) و يتحكم أيضًا في هرمون النمو والبرولاكتين من خلال الفص الأمامي. مخازن الفص الخلفي الهرمونات (الأوكسيتوسين وأيضًا هرمون ADH) التي يتم إفرازها فعليًا بواسطة منطقة ما تحت المهاد. كما أن هناك الغدد جارات الدرق (الغدة جارات الدرق) (المسؤولة عن تنظيم الكالسيوم و مستويات الفوسفور في العظام والدم) وغدة البنكرياس التي تفرز الأنسولين والجلوكاجون.

أمراض الغدة الدرقية

تفرز الغدة الدرقية الهرمونات T4 (ثيروكسين T4) و T3 (ثلاثي لودوثيرونين T3) تحت تأثير هرمون TSH (هرمون تحفيز الغدة الدرقية) الذي تفرزه الغدة النخامية (الأمامية الفص)، والذي يتم إفرازه تحت تأثير هرمون تحرير الثيروتروبين (TRH) من الوطاء.

فحص الغدة الدرقية :-

• يتم إجراء اختبارات وظائف الغدة الدرقية على النحو التالي:

1. قياس مستوى هرمون TSH، هرمون T4 الحر، هرمون T3 الحر في البلازما.
2. الموجات فوق الصوتية على الغدة الدرقية.
3. فحص اليود المشع للغدة الدرقية وكذلك التكنيشيوم. التكنيشيوم -99م، أناتما 123
4. قياس مستوى الأجسام المضادة ضد الثيروجلوبولين (الثيروجلوبولين)، مستقبل TSH الأجسام المضادة.
5. شطف الغدة الدرقية بإبرة دقيقة للفحص المرضي.

• فرط نشاط الغدة الدرقية (زيادة إفراز الغدة الدرقية)

• الأسباب

1. مرض جريفز.
2. ورم غدي انفرادي سام.

3. سامة متعددة العقيدات (غير سرطانية)

4. التهاب الغدة الدرقية.

5. أورام الغدة الدرقية.

6. أورام الغدة النخامية.

أعراض فرط نشاط الغدة الدرقية:

1. العصبية / القلق.

2. التعرق الزائد.

3. خفقان القلب.

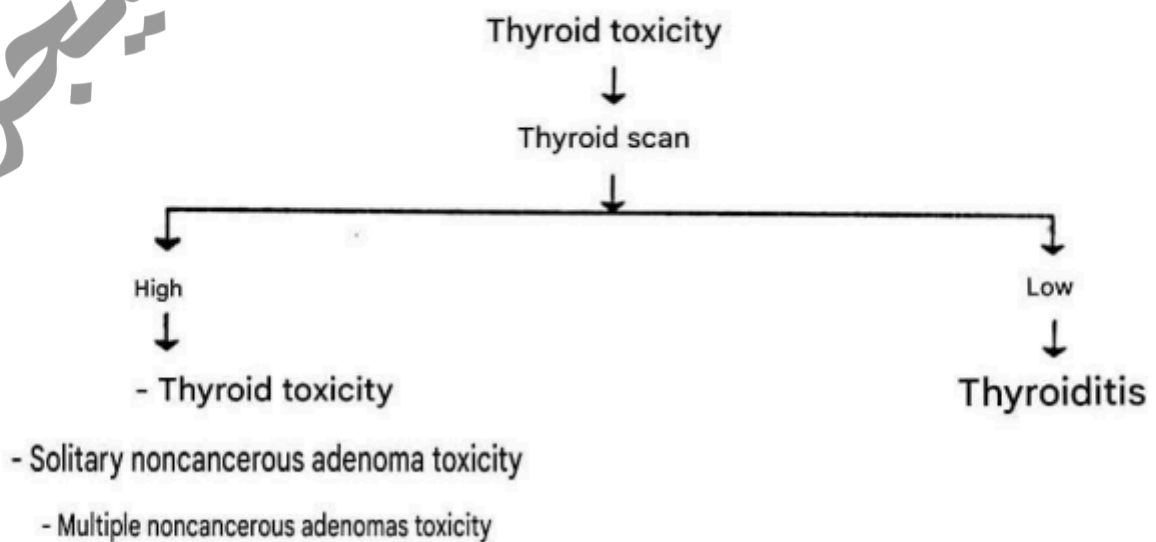
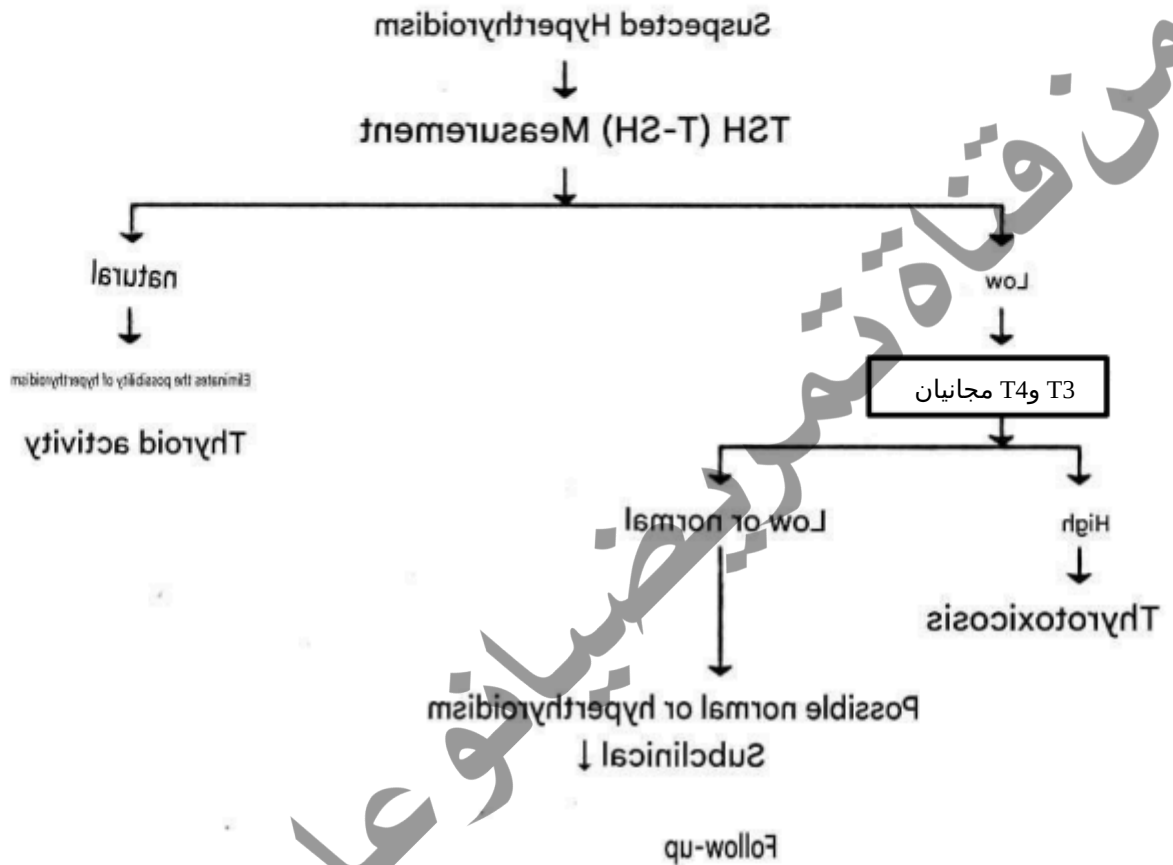
4. التعب وفقدان الوزن مع زيادة الشهية.

5. ضيق في التنفس.

6. ارتعاش اليد.

7. جحوظ العين (بروز العينين).

• التشخيص:



• العلاج:

- 1- أقراص كاريمازول (نيومركازول) 5 ملغ.
الأسبوع صفر-3: 15 ملغ كل 8 ساعات.
الأسابيع 4-8: 10 ملغ كل 8 ساعات.
ثم استمر في تناول الجرعة بجرعة 5-20 ملغ يومياً لمدة 12-18 شهراً.
- الآثار الجانبية للدواء: انخفاض خلايا الدم البيضاء - طفح جلدي.

- 2- تتم إضافة حاصرات بيتا (بروبرانولول) (بروبرانولول 160 ملغ/يوم).
- 3- العلاج الجراحي.
- 4- العلاج الإشعاعي.

قصور الغدة الدرقية (قصور الغدة الدرقية)

• الأسباب:

- التدمير المناعي الذاتي للغدة الدرقية
- التهاب الغدة الدرقية المناعي الذاتي
- العلاج الإشعاعي (العلاج الإشعاعي)
- الاستئصال الجراحي للغدة الدرقية (استئصال الغدة الدرقية)
- الأدوية الطبية مثل الليثيوم
- اضطرابات ما تحت المهاد

الأعراض:

- الأطفال: تأخر النمو العقلي - صعوبات التعلم - تأخر البلوغ.

- الكبار: التعب - عدم تحمل البرد - الخمول - زيادة الوزن - الإمساك - آلام المفاصل والعضلات - غزارة الطمث (فترات غزيرة) - تساقط الشعر - جفاف/خشونة الجلد - بطء معدل ضربات القلب (بطء القلب).

التشخيص:

- انخفاض مستوى T4 و T3 الحر في البلازما.
- ارتفاع مستوى TSH.
- فقر الدم.
- ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم.

العلاج:

يُعطى المريض أقراص ليفوثيروكسين 100 - 150 ميكروجرام / يوم.

يبدأ المرضى المسنون بجرعة 25 ميكروجرام / يوم ويزيدونها بمقدار 25 ميكروجرام كل أسبوعين.

مرض السكري (DM)

تعريف مرض السكري :-

يشكل داء السكري مجموعة متنوعة من الأمراض الأيضية التي تتميز بالارتفاع المزمن في مستويات السكر في الدم واضطراب في استقلاب الكربوهيدرات والدهون وكذلك البروتينات، نتيجة لنقص إفراز هرمون الأنسولين أو نقص فعالية الهرمون.

يعتبر الارتفاع المزمن في مستويات السكر في الدم أثناء الصيام وبعد الأكل (ساعتين) مسؤولاً بشكل مباشر عن المضاعفات الحادة والمزمنة لمرض السكري والتي تؤثر لاحقاً على جميع الأعضاء والأنظمة الحيوية في الجسم.

تصنيف مرض السكري :-

يتم تصنيف مرض السكري حسب أسباب ظهوره:-

1- مرض السكري من النوع الأول (T1 DM):

يحدث عادة عند الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا ولكن يمكن أن يحدث عند كبار السن؛ وفي هذه الحالة، يطلق عليه مرض السكري المناعي الذاتي الكامن في مرحلة البلوغ (LADA).

النوع الأول يتميز بنقص مطلق في هرمون الأنسولين بسبب التدمير المناعي الذاتي للغدة البنكرياسية.

2- مرض السكري من النوع الثاني (T2 DM):

يحدث عادة عند الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا ولكن يتم تشخيصه أيضًا عند المرضى الذين لا تتجاوز أعمارهم 9 سنوات والذين يتميزون بالسمنة الشديدة وقلة النشاط البدني؛ في هذه الحالة، يطلق عليه مرض السكري عند النضج لدى الشباب (MODY).

• ينشأ مرض السكري من النوع الثاني بسبب:

أو مقاومة الأنسولين.

أو اضطراب وظيفي في خلايا بيتا المسؤولة عن إفراز الأنسولين. أو زيادة امتصاص السكر في الأمعاء الدقيقة. أو زيادة إنتاج السكر من الكبد.

3 - داء السكري الحُملي (GDM):

ويظهر مع ارتفاع مستوى السكر في الدم أثناء الحمل، وعادة ما يختفي بعد الولادة.

4- أنواع أخرى من مرض السكري التي تحدث نتيجة:

1. الأمراض التي تصيب البنكرياس.
2. زيادة إفراز هرمون النمو والكورتيكوستيرويدات.
3. استخدام بعض الأدوية مثل مدرات البول.
4. العوامل الوراثية التي تسبب انخفاض حساسية الأنسجة لهرمون الأنسولين.
5. نقص أو خلل في مستقبلات الأنسولين على مستوى الأنسجة.

تشخيص مرض السكري:

(1) الأعراض الرئيسية لمرض السكري من النوع الأول والنوع الثاني:

النوع الثاني	النوع الأول	الأعراض
+	++	كثرة التبول + العطش
+	++	الشعور بالتعب
-	++	الإفراط في تناول الطعام + فقدان الوزن
++	+	عدم وضوح الرؤية
++	+	الحكة التناسلية عند الإناث
++	+	خدر في الأطراف
-	++	سلس البول الليلي

(2) الفحص المخبري:

يتم تشخيص داء السكري عندما يكون مستوى الجلوكوز في الدم أثناء الصيام أعلى من 126 ملغم/ديسيلتر، أو مستوى الجلوكوز في الدم بعد ساعتين من تناول الطعام (بعد الأكل) أعلى من 200 ملغم/ديسيلتر أو أن مستوى الجلوكوز في الدم العشوائي أعلى من 200 ملغم/ديسيلتر في أكثر من قراءة.

مرض السكري	ضعف تحمل الجلوكوز	ضعف نسبة الجلوكوز في الصيام	عادي	مستوى الجلوكوز في البلازما
≤ 126 ملغم/ديسيلتر	–	$\geq 110 - 125$ ملغم/ديسيلتر	> 110 ملغم/ديسيلتر	صيام
≤ 200 ملغم/ديسيلتر	$\geq 140 - 199$ ملغم/ديسيلتر	–	> 140 ملغم/ديسيلتر	ساعتين بعد الأكل
≤ 200 ملغم/ديسيلتر	–	–	–	عشوائي

مراقبة مرض السكري:-

يتم مراقبة مرض السكري على النحو التالي:

- 1- قياس مستوى السكر في الدم الشعري من قبل المريض نفسه طوال اليوم. 2- قياس مستويات الجلوكوز في البلازما أثناء الصيام وبعد الأكل بساعتين كل 3 أشهر.
- 3- قياس مستوى الهيموجلوبين السكري (HbA1c) كل شهرين (الطبيعي أقل من 6%). 4- قياس مستويات الدهون ووظائف الكلى.

علاج مرض السكري :-

أهداف علاج مرض السكري:-

- 1- معالجة الأعراض التي يشكو منها المريض.
- 2- الإسراع بعودة الحالة الفسيولوجية والاجتماعية للمريض إلى طبيعتها. 3- الوقاية أو تأخير المضاعفات المرتبطة بمرض السكري.

نظام العلاج :-

تبدأ خطة العلاج على النحو التالي:-

(أ) العلاج التريوي:-

- شرح مبسط لطبيعة المرض وأعراضه ومضاعفاته بالنسبة للمريض.
- تثقيف المريض حول العناية بالقدم.
- تعليم المريض كيفية قياس مستويات السكر في الدم باستخدام الأجهزة الحديثة المتوفرة لإجراء الاختبار الفوري.
- ينصح المريض بالإقلاع عن التدخين وتجنب التوتر العصبي.
- ينصح المريض بالمشي لمدة نصف ساعة يوميًا.

(ب) العلاج الغذائي:

يختلف العلاج الغذائي من مريض لآخر حسب العادات الغذائية والجهد البدني وطبيعة العمل والظروف المالية.

وينصح بموازنة السعرات الحرارية بحيث تتراوح نسبة البروتينات من 15-20%، والدهون 30%، والكربوهيدرات 50-60%.

(ج) التمرين:

يوصى بممارسة التمارين الرياضية يوميًا لمدة نصف ساعة، وخاصة المشي، نظرًا لفوائدها في التحكم في الوزن، وخفض مستويات الدهون والكوليسترول، وربما تقليل جرعات الأدوية.

(د) العلاج الدوائي:

- 1- أدوية خفض سكر الدم عن طريق الفم. 2- الأنسولين.

نحن نستخدم عوامل خفض سكر الدم عن طريق الفم أو الأنسولين لتحقيق مستويات السكر المستهدفة التالية.

هدف	عادي	
> 110 ملغم/ديسيلتر	> 100 ملغم/ديسيلتر	سكر الصيام
> 140 ملغم/ديسيلتر	> 140 ملغم/ديسيلتر	سكر بعد الأكل لمدة ساعتين
100 - 140 ملغم/ديسيلتر	> 110 ملغم/ديسيلتر	سكر ما قبل النوم
> 6.5%	> 6%	مستوى الهيموجلوبين السكري التراكمي

الانسولين

• يوصى باستخدام الأنسولين لعلاج مرض السكري في الحالات التالية:

او مرض السكري من النوع الأول.

أو مرض السكري من النوع 2 لا يستجيب للعلاج بعوامل خفض السكر عن طريق الفم والتحكم في النظام الغذائي. أو أثناء العمليات الجراحية والالتهابات وأثناء الحمل.

أو عندما يكون ارتفاع نسبة السكر في الدم مصحوبًا بوجود الكيتونات في الدم وزيادة حموضة الدم (الحماض الكيتوني السكري).

يتم حساب جرعة الأنسولين على أنها 0.5 إلى 1 وحدة من الأنسولين لكل كيلوغرام من وزن الجسم على مدار اليوم. يتم تقسيم الجرعة الإجمالية المحسوبة على النحو التالي: 2/3 من الجرعة في الصباح و 1/3 من الجرعة في المساء.

• أنواع الأنسولين

نوع الأنسولين	بدء العمل ذروة العمل مدة العمل		
عادي (أكترايد، هومولين آر)	1 - 1/2 ساعة	2 - 3 ساعات	5 - 8 ساعات
NPH (إنسولاتارد، هومولين ن)	2 - 4 ساعات	6 - 8 ساعات	6 - 16 ساعة
لينتي (نوفولينتي، هومولين إل)	6 - 8 ساعات	8 - 12 ساعة	12 - 24 ساعة
مخلوط مسبقاً (هومولين 70/30) (ميكستارد 70/30)	4 - 8 ساعات	8 - 14 ساعة	25 - 36 ساعة
ليسبرو قصير المفعول للغاية (Humalog، Novorapid)	> 15 دقيقة	1 ساعة	4 - 5 ساعات
ألترالينتي جلارجين (لانتوس)	1 - 2 ساعة	-	22 - 24 ساعة

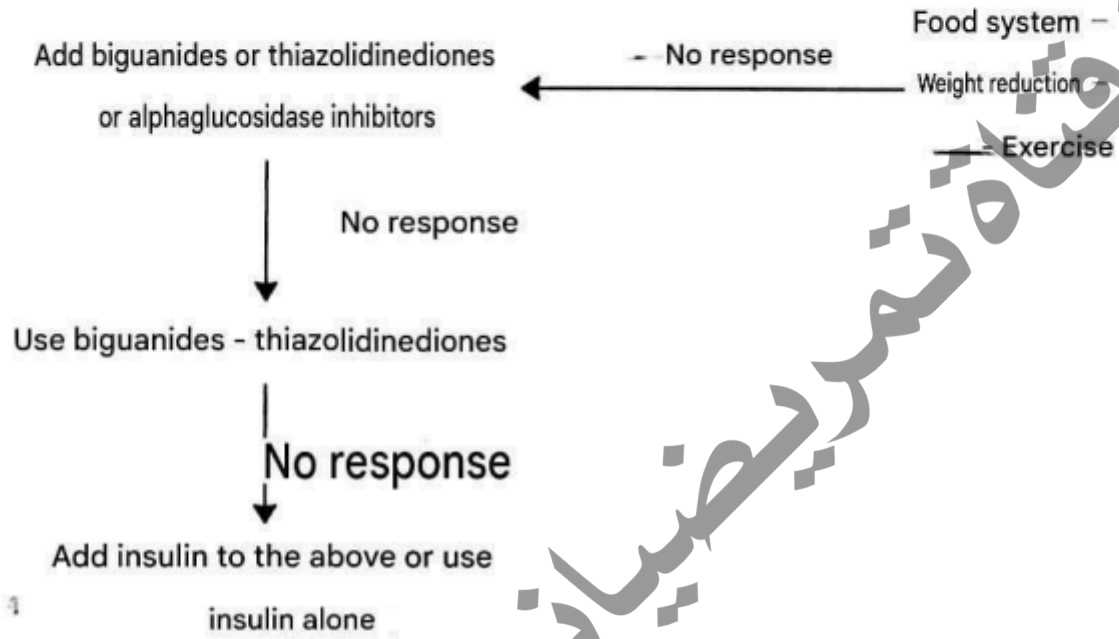
عوامل خفض سكر الدم عن طريق الفم:-

يتم استخدامها لعلاج مرض السكري من النوع الثاني وتنقسم إلى عدة أنواع:-

نوع	السلفونيل يوريا (على سبيل المثال، دياميكرون)	الجلوكوفاج البيجوانيدات (على سبيل المثال، أكاربوز)	الثيازوليدينونيات (على سبيل المثال، أفانديا)	ميجليتينيديات (على سبيل المثال، نوفونورم)
آلية	زيادة إفراز الأنسولين إنتاج البنكرياس	يقلل من الكبد يقلل من تناول الأطعمة السكرية بكميات صغيرة الأمعاء	يحسن مقاومة الأنسولين تقليل إنتاج الجلوكوز الكبد	يزيد من إفراز الأنسولين من البنكرياس
الملف الشخصي للمريض	العمر < 30 سنة الوزن الطبيعي	- السمنة ارتفاع نسبة السكر بعد الأكل بساعتين ارتفاع نسبة السكر في الصيام نسبة عالية من الدهون	- السمنة ضعف وظائف الكلى نسبة عالية من الدهون	ارتفاع نسبة السكر بعد الأكل بساعتين
التوقيت	30 دقيقة قبل الوجبات	مع الوجبات	مع وجبة الإفطار	15 دقيقة قبل الوجبات

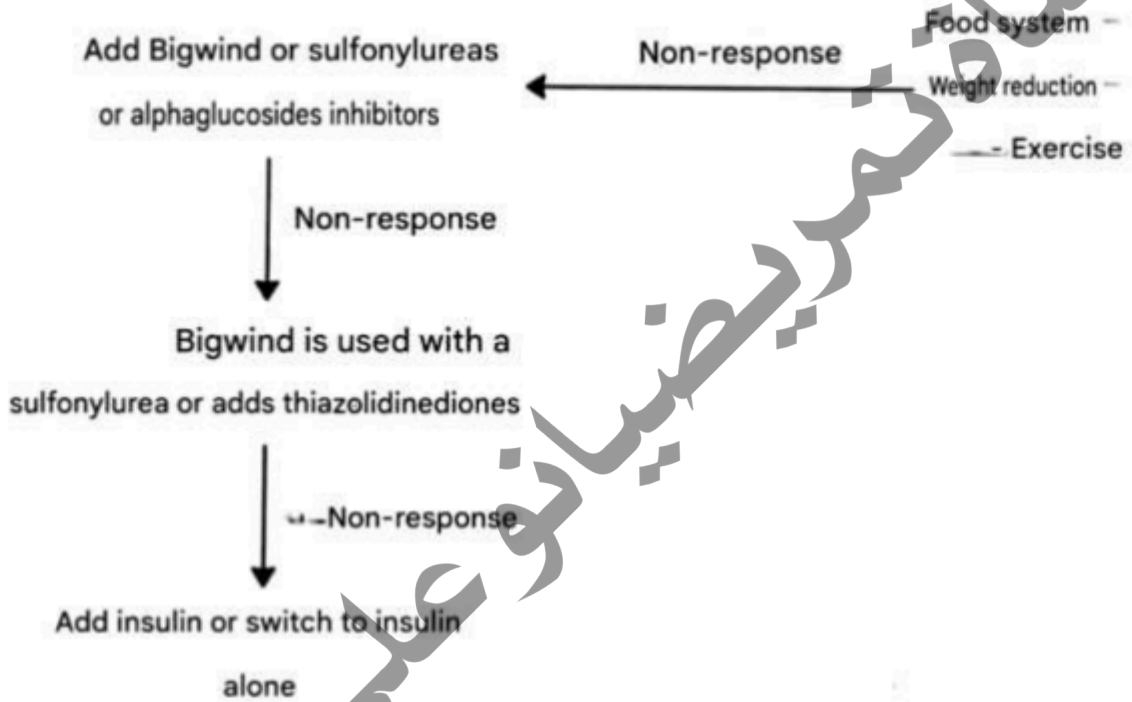
رسم توضيحي لعلاج مرضى السكري من النوع الثاني المصابين بالسمنة :-

An illustration of the treatment of type 2 diabetes patients with obesity:



رسم توضيحي لعلاج مرضى السكري من النوع الثاني ذوي الوزن الطبيعي:-

Illustration of the treatment of type 2 diabetes patients with normal weight:



الجزء الثامن

الأمراض المعدية

يمكن أن تؤثر الأمراض المعدية على جميع الأعضاء أو أجهزة الجسم المختلفة. تختلف الأمراض المعدية عن الأمراض الأخرى من حيث أنها تسببها كائنات حية مجهرية تشمل البكتيريا - الفيروسات - الفطريات - الطفيليات. تنتقل العدوى من إنسان إلى آخر عبر طرق متعددة.

مصدر وطريق العدوى	طريقة الإرسال	أمثلة على الأمراض المعدية
أ- الاتصال :- 1- الاتصال بين البشر: 2- التلامس مع التربة: 3- التعرض للمياه الملوثة.	لامسة الجلد والأغشية المخاطية الجروح - السحجات اختراق الجلد	-الجرب -التيتانوس -داء البلهارسيا
ب- المحمولة جواً:-	قطرات - غبار	الحصبة - الحصبة الألمانية (الحصبة الألمانية) - التهاب السحايا
ج- الطريق البرازي الفموي:-	تلوث الغذاء/الماء بالنفايات البرازية	التيفوئيد - التهاب الكبد (أ)
د- من خلال المشيمة:-	دم الأم	الحصبة الألمانية (الحصبة الألمانية) - داء المقوسات
هـ- التدخل الطبي:-	حقن	التهاب الكبد الفيروسي (ب)
ف- الحيوانات :-	حليب البيض	داء البروسيلا مرض السل

الوقاية من الأمراض المعدية :-

- النظافة الشخصية.
- التأكد من خلو الأغذية ومياه الشرب من التلوث

- التطعيم ضد الأمراض المعدية

حمى التيفوئيد السالمونيلا التيفية السالمونيلا نظيرة التيفية

يصاب البشر بحمى التيفوئيد عن طريق تناول الطعام أو الشراب الملوث ببراز حامل المسبب بكتيريا أو مريض مصاب بالتيفوئيد. لكي تحدث العدوى، يجب تناول ما يقرب من 10^6 إلى 10^8 البكتيريا ضرورية.

تخترق السالمونيلا جدار الأمعاء إلى الجريبات اللمفاوية (يقع باير). حيث يتكاثر ثم يدخل الدم، ثم إلى الكبد والطحال ونخاع العظام، وكذلك المرارة حيث يؤدي إلى حمل مزمن ويصبح المريض حاملاً للمرض.

مدة حضانة المرض 14 يومًا.

الأعراض :-

الاسبوع الاول: ارتفاع تدريجي في درجة الحرارة لمدة 4-5 أيام - قشعريرة - صداع - دوار - ألم في الأطراف - إمساك أو إسهال - النبض بطيء بالنسبة للحمى (بطء القلب النسبي).

نهاية الاسبوع الاول: تظهر بقع وردية على الجزء العلوي من البطن والظهر تتلاشى عند الضغط عليها - تضخم الطحال - انتفاخ البطن.

نهاية الاسبوع الثاني: قد تحدث مضاعفات مثل:

• فقدان التركيز - التهاب الصفاق - التهاب العظم والنقي.

التشخيص :-

1- تعداد الدم الكامل (وجود انخفاض في عدد خلايا الدم البيضاء - نقص الكريات البيض).
2- زراعة الدم في الاسبوع الأول.

3- ثقافة البراز في الاسبوع الثاني.

4- اختبار فيدال للتأكد من وجود أجسام مضادة لبكتيريا السالمونيلا في الاسبوع الثالث مع ارتفاع مطرد، لكنه اختبار غير موثوق به.

العلاج :-

أقراص سيبروفلوكساسين 500 ملغ كل 12 ساعة لمدة 14 يومًا. أو سيفوتاكسيم وريدًا 1 جرام كل 12 ساعة لمدة 14 يومًا.

علاج الناقل :-

أقراص سيبروفلووكساسين 500 ملغ كل 12 ساعة لمدة 4 أسابيع، وإذا لم يكن هناك استجابة، يتم النظر في استئصال المرارة.

الوقاية من التيفوئيد:-

- تطعيم المخالطين باللقاح الوقائي.
- استخدام الماء النقي.
- ضمان صحة العاملين في مجال الأغذية في المؤسسات التجارية والفنادق.

الحصبة

تحدث العدوى عن طريق استنشاق قطرات من مريض الحصبة الذي يحمل (فيروس باراميكسوفيروس). ويصيب الأطفال في كثير من الأحيان بعد اختفاء الأجسام المضادة التي تنتقل إليهم من الأم عبر المشيمة.

فترة الحضانة 10 أيام. يمكن أن تنتقل العدوى من المريض إلى المخالطين منذ بداية ظهور الأعراض حتى اختفاء الطفح الجلدي.

الأعراض :-

اليوم الأول: حمى - سيلان الأنف - زيادة إفرازات العين.

اليوم الثاني: السعال - خوف المريض من الضوء (رهاب الضوء) - بقع بيضاء صغيرة على الغشاء المخاطي للفم (بقع كوبليك). بعد ثلاثة أو أربعة أيام: طفح جلدي أحمر خلف الأذنين وعلى الجبهة ينتشر خلال ساعات في جميع أنحاء الجسم.

اليوم السادس أو السابع: تنخفض الحمى ويبدأ الطفح الجلدي بالاختفاء.

المضاعفات :-

- التهاب الأذن الوسطى - التهاب الرئوي
- التهاب الدماغ - الدنف - فقدان الوزن.

العلاج :-

عزل المريض لمدة 10 أيام من بداية الطفح الجلدي.

الوقاية :-

تطعيم الأطفال بلقاح MMR (الحصبة - النكاف - الحصبة الألمانية) تحت الجلد.

• إعطاء الغلوبولين المناعي لمخالطي مرضى الحصبة الذين تقل أعمارهم عن 18 شهرًا والأطفال الذين يعانون من ضعف المناعة.

الحصبة الألمانية (روبيلا)

وتنتقل العدوى عن طريق استنشاق قطرات من مريض يحمل (فيروس توجا). فترة الحضانة 18 يوما. وعادة ما يؤثر على الأطفال الأكبر سنا والمراهقين.

عندما يحدث المرض عند البالغين، تزداد شدته ويمكن أن يؤثر على النساء الحوامل في الأشهر الأربعة الأولى من الحمل.

الأعراض :-

- 1- حمى خفيفة.
- 2- طفح جلدي على الوجه والرقبة ينتشر إلى الجسم ثم إلى الأطراف.
- 3- تضخم الغدد الليمفاوية في الرقبة.
- 4- آلام المفاصل وانخفاض الصفائح الدموية عند البالغين.

العلاج :-

- الراحة في الفراش وعزل المريض.
- في حالة إصابة المرأة الحامل بالمرض خلال الأشهر الأربعة الأولى من الحمل، يتم إنهاء الحمل يوصى بالحمل لمنع تشوهات الجنين.

الوقاية :-

- إعطاء لقاح MMR.

النكاف

تنتقل العدوى عن طريق استنشاق قطرات من مريض يحمل الفيروس.

فترة الحضانة 18 يوما.

• الأعراض:

1- الحمى.

2- ألم في زاوية الفك يتبعه تورم مؤلم في الغدة اللعابية (الغدة النكفية). 3- تورم الغدة اللعابية الأخرى (الغدة تحت الفك السفلي).

• المضاعفات:

1- التهاب الخصية (التهاب الخصية). 2-

التهاب المبيض (التهاب المبيض). 3-

التهاب البنكرياس.

4- التهاب السحايا والدماغ (التهاب الدماغ والسحايا).

• العلاج:

عزل المريض + علاج الأعراض. استخدام أدوية الكورتيكوستيرويد في حالة حدوث التهاب الخصية.

• الوقاية:

استخدام لقاح MMR.

الجزء التاسع

أمراض الجهاز العصبي

كوما

حالة اليقظة تعتمد على :-

• سلامة التنشيط الشبكي، وهو عبارة عن مجموعة من النوى في جذع الدماغ ومنطقة ما تحت المهاد والمهاد. ويستقبل المنبهات والتنبهات وينقلها عبر مجموعة من الألياف العصبية الصاعدة إلى القشرة المخية لتنشيطها للقيام بالوظائف الحيوية.

• سلامة القشرة المخية.

الأسباب :-

Causes of Coma

Organic

Hysterical
Hysterical

Extracranial

Intracranial

Coma without Collateral Signs

Coma + Collateral Signs

Coma associated with a disturbance -

Road Accidents -

Metabolism (DK).

- Encephalitis - Inflammation of the lining membranes
of the brain.

Heart failure -

Brain abscess -

Respiratory Failure -

Renal Failure -

Severe hypertension -

- Liver Failure

Cerebral Circulation Constriction or Obstruction -

Septicaemia -

Brain Tumors -

Hypothyroidism -

Epileptic Seizures -

العلامات العصبية الجانبية للغيوبة الدماغية:-

- 1- عدم تناسق الوجه.
- 2- ردود الفعل الوترية العميقة غير المتماثلة.
- 3- انحراف العينين إلى جانب واحد.
- 4- تحول الرأس إلى جانب معين.
- 5- انخفاض أو زيادة قوة العضلات في جانب واحد (نقص التوتر أو فرط التوتر).
- 6- التلاميذ غير المتكافئين.

التشخيص :-

- 1- الحصول على التاريخ الطبي من الأقارب.
- 2- قياس ضغط الدم ومعدل ضربات القلب ودرجة الحرارة.
- 3- مراقبة معدل التنفس.
- 4- مراقبة مستوى السكر في الدم.
- 5- رائحة التنفس: رائحة الأسيتون (غيوبة ناتجة عن ارتفاع نسبة السكر في الدم)، رائحة الأمونيا (غيوبة كبدية).
- 6- ملمس الجلد (جاف - رطب - شقوق - علامات الحفن...).
- 7- الفحص العصبي.
- 8- تعداد الدم الكامل.
- 9- وظائف الكبد والكلية.
- 10- البزل القطني (تحليل السائل الدماغي الشوكي).
- 11- التصوير المقطعي للدماغ - التصوير بالرنين المغناطيسي.

العلاج :-

- 1- علاج السبب.
- 2- رعاية المريض في غيبوبة.
- 3- شطف إفرازات الجهاز التنفسي.
- 4- إدخال قسطرة بولية.

- 5- حساب مدخلات ومخرجات السوائل.
- 6- حقنة شرجية يومية.

- 7- قم بإدخال أنبوب أنفي معدي للطعام المخلوط.
- 8- إدخال قسطرة وريدية لإعطاء السوائل المطلوبة.

التهاب السحايا

التهاب السحايا هو التهاب الأغشية المحيطة بالدماغ ويحدث نتيجة لعدوى ميكروبية (بكتيريا - فيروسات - فطريات) أو لأسباب غير ميكروبية. البكتيريا المسببة هي:

- النيسرية السحائية
- المستدمية النزلية
- المكورات الرئوية
- العقدية

ويظهر المرض على شكل حالات متفرقة أو في شكل وبائي.

وينتقل المرض عن طريق الرذاذ، خاصة في الأماكن المزدحمة مثل المدارس والثكنات العسكرية. يصيب عادة الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 15 عامًا.

تعيش البكتيريا في منطقة البلعوم الأنفي (البلعوم الأنفي) وتصل إلى أغشية الدماغ عن طريق الدم أو مباشرة عن طريق الانتشار من بؤرة قريبة مثل الجيوب الأنفية.

الأعراض

الحمى - التهيج - الارتباك - تدهور التركيز والوعي - تصلب عضلات الرقبة. طفح جلدي يتميز باللون الأرجواني (نمشات/أرجوانية). يعاني بعض المرضى (20% من المرضى) من النوبات.

تشخيص

(ثقب الخشب)

1- البزل القطني وفحص السائل النخاعي.

أ- زيادة عدد العدلات (500-10000 خلية/ميكرو لتر)

ب- انخفاض مستوى الجلوكوز أقل من 40 ملغم/ديسيلتر (عادي ~50-80 ملغم/ديسيلتر).

ج- زيادة مستوى البروتين بأكثر من 150 ملغم/ديسيلتر (عادي ~20-40 ملغم/ديسيلتر*). د- زيادة ضغط السائل النخاعي.

2- التعرف على نوع البكتيريا المسببة عن طريق صبغة جرام.

3- زراعة السائل النخاعي والدم والسوائل الناتجة عن الآفات الجلدية وكذلك مسحة البلعوم الأنفي.

العلاج:

عند التأكد من الإصابة بالنييسرية أو المكورات الرئوية (المكورات الرئوية)، أعط سيفترياكسون 2 جرام في الوريد / كل 12 ساعة.

أو البنسلين المائي 20 مليون وحدة وريدية يومياً.

في حالة الإصابة ببكتيريا المستدمية النزلية، يتم إعطاء المريض سيفترياكسون 2 جرام / كل 12 ساعة.

الوقاية:

- يتم إعطاء المخالطين أقراص ريفامبيسين 600 ملغ لمدة يومين (للبالغين).
- الأطفال أقل من سنة واحدة: 5 ملغم/كغم/12 ساعة ريفامبيسين.
- يتم إعطاء الأطفال 0.5 مل تحت الجلد من اللقاح ضد العدوى البكتيرية النييسرية. (التطعيم)

الجزء العاشر

الأمراض الجلدية والتناسلية

أهداف الدراسة :-

- 1- التعرف على بعض الأمراض الجلدية الأكثر شيوعاً.
- 2- تعليم طرق انتقال الأمراض الجلدية المعدية وطرق الوقاية منها.
- 3- التعرف على طرق العلاج المختلفة مع التركيز على دور التمريض في العلاج وارتداء الملابس. 4- شرح أعراض الأمراض الجلدية المصاحبة لبعض الأمراض الباطنية.

بعض الأمراض الجلدية المعدية الشائعة الأمراض الجلدية الناتجة عن الالتهابات الطفيلية

1- الجرب:

- مرض معدٍ يسببه سوس الجرب.
- فترة الحضانة 14 يوماً.
- الأعراض: حكة شديدة، خاصة قبل النوم، وتؤثر على أكثر من فرد من أفراد الأسرة.
- ينتشر المرض عن طريق الاتصال.
- يظهر المرض على شكل حطاطات صغيرة، خاصة بين الأصابع، وكذلك الساقين والذراعين والإبطيين والفخذين والأعضاء التناسلية وتحت الثديين عند النساء.
- يُشار إلى أن المرض لا يصيب الوجه أو الجزء العلوي من الظهر.

العلاج:

- يجب عزل المريض وعدم استخدام فراشه وأدواته، ويجب غسل ملابس المريض بشكل منفصل.
- في حالة دخول المريض إلى المستشفى يجب عزله وإخطار إدارة المستشفى.
- علاج المريض وجميع أفراد الأسرة في وقت واحد بسبب احتمال وجودهم في فترة الحضانة.
- إعطاء المريض مضادات الهيستامين لعلاج الحكة.

• العلاج الموضعي للجرب: الاستحمام بالماء الدافئ والصابون، وفرك الجسم بالليفة، في المساء قبل النوم. بعد تجفيف الجسم، ضعي أحد مراهم الجرب المحددة مثل بنزوات البنزيل، أو الليندين (الجامين)، أو البيرميثرين (الأكتوميثرين) على الجسم كله باستثناء الرأس. كرر العلاج لمدة ثلاثة أيام متتالية.

2- القمل (قمل الرأس):

- مرض طفيلي يصيب فروة الرأس والشعر.
- وبصيص هذا المرض أطفال المدارس، وخاصة الفتيات، ويسبب حكة شديدة مع ظهور البثور والدمامل على الرأس مصحوبة بتورم الغدد الليمفاوية في الرقبة.

العلاج :-

يجب غسل الشعر جيداً؛ الحلاقة ليست ضرورية. قم بتمشيط الشعر جيداً بمشط ذو أسنان دقيقة ثم ضع عليه كريمات مضادة للقمل.

الأمراض الجلدية الناتجة عن التهابات الفيروسية

1- الثآليل :-

- تظهر على شكل حطاطات صغيرة على سطح الجلد.
- وينتقل المرض عن طريق اللمس ولا يسبب الحكة.
- وينتشر المرض إلى العديد من مناطق الجسم مثل الوجه واليدين والقدمين.
- هناك نوع من الثآليل ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي ويؤثر على الأعضاء التناسلية.

العلاج :-

- يمكن إزالة الثآليل باستخدام الكي الكهربائي، أو العلاج بالتبريد (التجميد)، أو الليزر.
- يمكن أيضاً علاج الثآليل موضعياً بحمض الساليسيليك.
- علاج الثآليل التناسلية بمحلول بودوفيلين؛ يجب أن يتم هذا التطبيق من قبل الطبيب ويتم غسله بعد أربع إلى ست ساعات.

2- جدري الماء:

- مرض فيروسي ينتقل عن طريق الرذاذ ويصيب الأطفال.
- فترة الحضانة: أسبوعين.
- يظهر المرض على شكل حطاطات صغيرة، ثم تظهر عليها حويصلات صغيرة، ثم تنفتح وتتقشر.
- ويصاحب ذلك حمى طفيفة.

العلاج :-

يختفي المرض تلقائيًا بعد أسبوعين، ولكن يجب العناية بالجلد بالمطهرات، ولا ينبغي إزالة القشور من سطح الجلد لتجنب التندب.

3- الهربس البسيط:

- يظهر المرض على شكل حويصلات صفراء صغيرة مصحوبة باحمرار الجلد.
- يؤثر المرض على المناطق القريبة من فتحات الجلد مثل الأنف والفم.
- وهناك نوع آخر ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي ويؤثر على الأعضاء التناسلية.

العلاج :-

- يجب إعطاء الأدوية المضادة للفيروسات عن طريق الفم (مثل الأسيكلوفير أو زوفيراكس).
- العلاج الموضعي: مطهر مثل الكحول أو البنفسج الجنطاني (محلول أزرق).

4- الهربس النطاقي

القوباء المنطقية

- يظهر المرض على شكل حويصلات صفراء صغيرة مصحوبة باحمرار الجلد ويؤثر على منطقة معينة من الجسم مثل الجلد العصبي (مثل الذراع أو الساق) وقد يظهر على الظهر أو الصدر على جانب واحد من الجسم أو على الوجه.

• ويصاحب المرض ألم شديد في موقع الحويصلات، وقد يستمر الألم بعد اختفائها (الألم العصبي التالي للهربس).

العلاج :-

- ينبغي إعطاء مسكنات الألم.
- يجب إعطاء الأدوية المضادة للفيروسات عن طريق الفم (مثل الأسيكلوفير أو زوفيراكس).
- العناية بالبشرة بالمطهرات.

الأمراض الجلدية الناتجة عن الالتهابات البكتيرية

• الجلد السليم لا تخترقه البكتيريا، لذلك لكي تحدث أمراض جلدية بكتيرية، يجب أن يكون هناك خلل في الجلد، مثل الحكة المرتبطة بالجرب والأكزيما، أو الأمراض الباطنية مثل مرض السكري أو أمراض الكلى.

• ويظهر المرض على شكل بثرات صغيرة تتضخم وترتفع فوق سطح الجلد، وتمتلئ بالقيح، وتتحول إلى دمامل (دمامل)، ومن الممكن أن تنتشر إلى مناطق أخرى من الجسم.

العلاج :-

- علاج الأمراض التي تسبب حكة الجلد.
- إعطاء المضادات الحيوية عن طريق الفم.
- قم بمعالجة الآفات الجلدية باستخدام مطهر مثل محلول برمنجنات البوتاسيوم 1:8000 واستخدم مرهم مضاد حيوي (على سبيل المثال، مرهم جنتاميسين أو مرهم حمض الفوسيديك).

الأمراض الجلدية الناتجة عن الالتهابات الفطرية

- تصيب الفطريات فروة الرأس أو سطح الجلد أو الأظافر.
- الفطريات التي تصيب فروة الرأس تسبب سعفة الرأس (الدودة الحلقية).
- هناك نوعان من سعفة الرأس.

أ) سعفة الرأس (القوباء الحلقية الإنحليزية) :-

وينقسم إلى ثلاثة أنواع:

1- نوع الميكروسبوريك (إكتوثيريكس) :-

- وهو النوع الأكثر شيوعاً ويؤثر على فروة الرأس عند الأطفال.
- تظهر كم منطقة واحدة أو أكثر محددة على الرأس، مستديرة أو بيضاوية الشكل، مغطاة بقشور رمادية صغيرة.
- يتكسر الشعر المصاب بالفطريات، ويترك طوله من 1 إلى 3 ملليمترات فوق سطح الجلد. 2- نوع النقطة السوداء (إندوثيريكس) :-
- يصيب الأطفال والبالغين ويظهر كم منطقة محددة في الرأس مع التهاب طفيف حول بصيلات الشعر.
- يتكسر الشعر عند مستوى خروجه من فروة الرأس، فتظهر المنطقة المصابة على شكل بقعة ناعمة ذات نقاط سوداء.

3- فافوس (كيريون) النوع :-

- يؤثر على الأطفال والبالغين ويسبب التهاباً شديداً في بصيلات الشعر.
- يؤدي إلى ظهور قشور (درع) أو خراجات.
- هذا النوع يدمر بصيلات الشعر، وإذا أهمل العلاج يؤدي إلى تساقط الشعر ويترك ندبات حيث لا ينمو الشعر بعد ذلك.

العلاج :-

- عزل المريض وتوفير الرعاية الوقائية للمخالطين.
- إعطاء أقراص جريزوفولفين للمريض (يتم إعطاء المريض قرصاً واحداً لكل 10 كجم من وزن الجسم، ويجب إعطاء الدواء مباشرة بعد الوجبات).
- ضعي مرهماً مضاداً للفطريات على فروة الرأس (على سبيل المثال، ميكونازول (داكتارين) أو تيكونازول (تروسيد)).

ب - فافوس (تينيا فافوسا) :-

- يصيب الأطفال والبالغين من الجنسين ويتميز بظهور قشور جافة وهشة صفراء اللون ذات حواف مرتفعة ومركز منخفض مثل الصحن، ذات رائحة مميزة.
- يتغير لون الشعر ويصبح مغبراً، لكنه لا يتكسر.
- إذا تم إهمال العلاج فإنه يؤدي إلى تدمير بصيلات الشعر ويترك ندبات، ولا ينمو الشعر في المناطق المصابة.

العلاج :-

- على غرار علاج سعفة الرأس، بالإضافة إلى إزالة القشور الصفراء باستخدام مرهم حمض الساليسيليك.

الفطريات التي تصيب سطح الجلد

تسبب أنواعًا مختلفة من السعفة (الدودة الحلقية) اعتمادًا على موقع العدوى الجلدية.

1- سعفة الجسم (دودة الجسم الحلقية) :-

تظهر على شكل رقعة حمراء محددة مرتفعة قليلًا فوق سطح الجلد، مع وجود حويصلات أو قشور دقيقة على حدودها.

العلاج :-

- أقراص جريسوفولفين.
- استخدم مرهمًا مضادًا للفطريات.

2- سعفة الفخذ (حكة جوك) :-

يظهر على شكل التهاب جلدي على الجوانب الداخلية للفخذين العلويين، مع وجود حدود محددة مرتفعة قليلًا فوق سطح الجلد ومغطاة بحويصلات صغيرة أو قشور دقيقة.

العلاج :-

- العناية بنظافة الملابس الداخلية والنظافة الشخصية.
- إعطاء أقراص جريسوفولفين للمريض.
- استخدم مرهمًا مضادًا للفطريات.

3- سعفة القدم (قدم الرياضي) :-

التهاب الجلد بين أصابع القدم مصحوب بحكة، وموت طبقات الجلد العلوية مما يجعلها بيضاء ورطبة، وقد يصاحبه رائحة كريهة في القدمين.

العلاج :-

- احرص على إبقاء قدميك جافة قدر الإمكان، حيث تعمل الحرارة والرطوبة على تعزيز نمو الفطريات.
- تطهير الجوارب جيداً.
- أقراص جريزوفولفين.
- استخدم مرهمًا مضادًا للفطريات.

4- سعفة الظفر (فطريات الأظافر) :-

يؤثر على نمو الأظافر، مما يؤدي إلى خشونة الأظافر، وتآكلها، وظهور نتوءات عليها، وفقدان لمعانها.

العلاج :-

- أقراص جريزوفولفين لفترة طويلة، أو كبسولات فلوكونازول (ديفلوكان)، أو أقراص تيربينافين (لاميسيل).

5- سعفة المبرقشة (النخالية المبرقشة):-

- تتميز بظهور بقع مغطاة بقشور تتراوح ألوانها من الأصفر إلى البني الداكن.
- يظهر على الصدر والظهر والذراعين. هذا النوع من العدوى الفطرية السطحية لا يصاحبه حكة أو التهاب.

العلاج :-

- أقراص مضادة للفطريات (بخلاف الجريزوفولفين) مثل الفلوكونازول، أو الإيتراكونازول (سبورانوكس)، أو الكيتوكونازول.
- استخدم مرهمًا مضادًا للفطريات.
- العلاج بالأشعة فوق البنفسجية في بعض الحالات.

بعض الأمراض الجلدية غير المعدية

1- الصدفية :-

- وهو مرض جلدي غير معدٍ.
- يؤثر على 1-2% من الأشخاص وسببه غير معروف.
- يظهر المرض على شكل حطاطات حمراء صغيرة مغطاة بطبقة بيضاء متقشرة.
- عند إزالة القشور البيضاء تظهر نقاط نزيف صغيرة (علامة أوسبيتز).
- يمكن أن يظهر المرض في أي مكان من الجسم، ولكن المناطق الأكثر تأثراً هي الركبتين والمرفقين وأسفل الظهر.
- كما أنه يؤثر على فروة الرأس والأظافر.

العلاج :-

- العلاج الموضعي بمرهم حمض الساليسيليك ومرهم الكورتيزون.
- العلاج عن طريق الفم بأقراص الميثوتريكسيت.
- العلاج الضوئي بالأشعة فوق البنفسجية.

2- البهاق:

- وهو مرض جلدي غير معدٍ وسببه غير معروف.
- يظهر المرض على شكل بقع بيضاء في أجزاء مختلفة من الجسم ولا يسبب الحكة.
- ويمكن أن ينتشر إلى مناطق واسعة من الجسم.

العلاج:

- تطبيق موضعي بمحلول السورالين (على سبيل المثال، الميلادينين).
- الاستخدام مع مرهم الكورتيزون.
- إعطاء أقراص السورالين (على سبيل المثال، الميلادينين) متبوعاً بالتعرض لأشعة الشمس أو الأشعة فوق البنفسجية (علاج PUVA).

3- الأمراض الجلدية الفقاعية (مثل الفقاع، الفقاع):

وهي مجموعة من الأمراض التي تصيب الجلد، وتظهر على شكل حويصلات صغيرة وبثور تحتوي على سائل. عندما تفتح هذه الآفات، فإنها تترك تقرحات على الجلد.

العلاج:

- إعطاء جرعات عالية من الكورتيزون عن طريق الفم للمريض. وقد يؤدي هذا إلى ارتفاع ضغط الدم ومرض السكري،
- تسليط الضوء على دور الممرضة في مراقبة ضغط الدم بانتظام واختبار نسبة السكر في الدم والبول للكشف المبكر عن مرض السكري.
- تلعب الممرضة أيضًا دورًا مهمًا في العناية ببشرة المريض ومعالجتها مثل الجلد المحروق.

4- حب الشباب الشائع:

- مرض يصيب المراهقين من الجنسين بعد البلوغ بسبب زيادة إفراز الأندروجينات (الهرمونات الذكرية)، مما يسبب زيادة الإفرازات الدهنية في الجلد.
- ويظهر المرض على شكل بثور وبثرات على الوجه والصدر والكتفين، وعندما تختفي تترك ندوباً على الجلد.

العلاج:

- تقليل الأطعمة الدهنية في النظام الغذائي.
- تطبيق موضعي على الجلد لتقليل الإفرازات الدهنية (على سبيل المثال، الريتينويدات، بيروكسيد البنزويل).
- تطبيق المضادات الحيوية الموضعية.
- المضادات الحيوية عن طريق الفم.

5- الشرى (خلايا النحل):-

- وهو مرض جلدي غير معدي ينتج عن الحساسية لمجموعة من المواد مثل الطعام أو الأدوية أو التعرض لأشعة الشمس أو التغيرات المناخية أو بسبب أمراض جسدية كامنة.
- يظهر المرض على شكل انتفاخات بأحجام مختلفة في أجزاء مختلفة من الجسم، مصحوبة بحكة شديدة، وفي بعض الأحيان يمكن أن تكون الحساسية شديدة بما يكفي للتسبب في الاختناق (الحساسية المفرطة).

العلاج:

- في حالات الشرى الحاد يجب علاج المريض فوراً لمنع الاختناق. يتم إعطاء المريض حقنة الأدرينالين تحت الجلد أو حقنة الكورتيزون العضلية.

• بعد ذلك، يكون العلاج مشابهًا للشرى المزمن: مضادات الهيستامين عن طريق الفم وغسل الكالامين لتقليل الإحساس بالحكة.

• حدد السبب وتجنبه.

6- الشرى الحطاطي (الحكة البسيطة):-

نوع من الحساسية يصيب الأطفال بسبب لدغات الحشرات والبعوض.

• يظهر المرض على شكل حطاطات وحوصلات صغيرة مصحوبة بحكة شديدة تؤدي إلى ظهور عدوى بكتيرية على شكل بثرات صغيرة.

العلاج :-

• الوقاية من لدغات الحشرات والبعوض.

• إعطاء مضادات الهيستامين عن طريق الفم.

• استخدم العلاج الموضعي باستخدام مرهم الكالامين أو الكورتيزون.

• إعطاء المضادات الحيوية في حالة وجود عدوى بكتيرية.

الأكزيما (التهاب الجلد التأتبي):-

هو نوع من حساسية الجلد ذات عامل وراثي يصيب مختلف الأعمار.

الأكزيما التي تصيب الأطفال من عمر شهرين إلى سنتين:-

• تظهر الآفات على الوجه، وخاصة الخدين.

• يبدأ الأمر باحمرار الجلد المغطى بالقشور، ثم تظهر عليه حوصلات صغيرة.

الأكزيما التي تصيب الأطفال من عمر 5 سنوات إلى 12 سنة:-

• يؤثر على الجلد خلف الركبتين، وخلف المرفقين، والرقبة.

• تظهر على شكل حطاطات صغيرة مصحوبة بتحزز (سماكة) الجلد.

الأكزيما التي تصيب البالغين:-

• تظهر الآفات في نفس مناطق النوع السابق، مصحوبة بحكة شديدة مع زيادة تحزز الجلد.

العلاج :-

- إعطاء مضادات الهيستامين عن طريق الفم.
- استخدام مرهم الكورتيزون.

الثعلبة البقعية :-

- مرض غير معدي يؤدي إلى تساقط الشعر.
- هناك نوع يصيب جزء معين من الشعر ويظهر على شكل بقعة واحدة أو أكثر خالية من الشعر وبدون قشور أو التهاب.
- هناك نوع آخر من الأمراض يؤثر على كل شعر الرأس (الثعلبة الشاملة)، ويؤثر أحيانًا على كل شعر الجسم (الثعلبة الشاملة).

العلاج :-

- إذا كانت الإصابة مقتصرة على منطقة صغيرة من الجسم، ضعي مرهم الكورتيزون أو مرهم الكانثاريديات.
- في الحالات التي تؤثر على جزء كبير من فروة الرأس أو شعر الجسم، يتم إعطاء أقراص الكورتيزون.

الشعرانية عند النساء:-

- هو ظهور الشعر في المناطق التي لا يظهر فيها الشعر عادة عند النساء، مثل حول الفم والذقن والخصدين والرقبة.
- ويسبب هذا ضائقة واضطرابات نفسية لدى النساء.
- يظهر هذا الشعر بعد البلوغ بسبب زيادة إفراز الأندروجينات (الهرمونات الذكرية).

الأسباب :-

- قد يكون السبب غير معروف (مجهول السبب).
- سبب وراثي.

- نتيجة تناول بعض الأدوية.
- نتيجة لمتلازمة تكيس المبايض (PCOS) التي تؤدي إلى زيادة إفراز الأندروجين.
- زيادة إفراز هرمون البرولاكتين (فرط برولاكتين الدم).

العلاج :-

- تحديد السبب ومعالجته.
- إعطاء الأدوية المضادة للأندروجين.
- قم بإزالة الشعر الزائد باستخدام أجهزة الليزر أو أجهزة الضوء النبضي المكثف (IPL).

أعراض الجلد المرتبطة

مع بعض الأمراض الداخلية

1- الفشل الكلوي :-

- يصاحب الفشل الكلوي حكة في أجزاء كثيرة من الجسم، وأحياناً تكون الحكة شديدة.

العلاج:

إعطاء مضادات الهيستامين عن طريق الفم، وفي بعض الحالات يتم استخدام العلاج بالأشعة فوق البنفسجية.

2- مرض السكري :-

يصاحب مرض السكري العديد من الأمراض الجلدية المعدية، سواء كانت بكتيرية أو فطرية أو فيروسية. وفي هذه الحالة يجب علاج مرض السكري، وعلاج الأمراض المعدية المختلفة بالعلاج المناسب.

3- التهاب الكبد الفيروسي سي :-

هذا المرض منتشر في مصر، وقد لوحظ ظهور العديد من الأمراض الجلدية المصاحبة له، مثل الحكة الشديدة والشرى، وكذلك ظهور الحزاز المسطح الذي يصيب الجلد على شكل حطاطات بنفسجية على سطح الجلد، ويظهر على شكل خطوط بيضاء على الغشاء المخاطي للفم داخل الفم.

الأمراض التناسلية

1- مرض الزهري :-

مرض تناسلي خطير ناجم عن الإصابة ببكتيريا حلزونية تسمى *Treponema pallidum*. ينقسم مرض الزهري إلى نوعين: الزهري المكتسب والزهري الخلقي.

(أ) مرض الزهري المكتسب:-

- تنتقل العدوى عن طريق الاتصال الجنسي، أو الاتصال بالآفات، أو نقل الدم.

• ينقسم مرض الزهري المكتسب إلى أربع مراحل:-
أو المرحلة الأولية: تسمى القرحة (القرحة الصلبة).

أو المرحلة الثانوية: تتميز بظهور طفح جلدي على الجلد والأغشية المخاطية وأعضاء الجسم الأخرى.

أو المرحلة الثالثة: تؤثر على الجلد والأغشية المخاطية والعظام والمفاصل والأعضاء الداخلية.
أو المرحلة الرابعة: تنقسم إلى الزهري القلبي الوعائي والزهري العصبي.

(ب) مرض الزهري الخلقي:

• تنتقل العدوى من الأم إلى الجنين عن طريق المشيمة.

• ينقسم مرض الزهري الخلقي إلى:-

أو الزهري الخلقي المبكر: يحدث في أول عامين من الحياة ويشبه المرحلة الثانوية من مرض الزهري المكتسب.

أو الزهري الخلقي المتأخر: تبدأ الأعراض بالظهور في حوالي السنة الرابعة والخامسة، وتتميز بظهور الآفات الصمغية كما في المرحلة الثالثة من الزهري المكتسب.

العلاج :-

إعطاء حقن البنسلين.

2- السيلان :-

مرض يتميز بإفرازات قيحية من الأعضاء التناسلية، ناجمة عن الإصابة ببكتيريا النيسرية البنية. فترة حضانة المرض تتراوح من 2 إلى 7 أيام.

طرق الإرسال:-

• الاتصال الجنسي.

• تنتقل العدوى من الأم إلى الطفل أثناء الولادة إذا كانت الأم مصابة.

أعراض مرض السيلان الحاد عند الرجال:-

• إفرازات قيحية من مجرى البول واحمرار والتهاب في مجرى البول.

• الشعور بالحرقان أثناء التبول مع زيادة وتيرة التبول.

• ارتفاع طفيف في درجة الحرارة.

أعراض مرض السيلان الحاد عند النساء:

- 1- إفرازات قيحية من مجرى البول والمهبل بسبب التهاب عنق الرحم.
- 2- الشعور بالحرقان أثناء التبول مع زيادة وتيرة التبول ووجود صديد في البول. 3- خروج القيح من فتحة عنق الرحم.

العلاج :-

- تجنب الاتصال الجنسي.
- إعطاء المضادات الحيوية.

3- الإيدز (متلازمة نقص المناعة المكتسب) :-

وهو مرض فيروسي ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي أو نقل الدم ويسبب فقدان مناعة الجسم.

الأعراض :-

- فقدان الوزن.
- الإسهال المزمن.
- التهاب الرئوي.
- تضخم الغدد الليمفاوية في أجزاء مختلفة من الجسم (اعتلال العقد اللمفية).
- ظهور أمراض معدية مختلفة سواء كانت طفيلية أو فيروسية أو بكتيرية أو فطرية بسبب نقص المناعة.

العلاج :-

- يجب عزل المريض.
- لا يوجد لقاح وقائي ضد هذا المرض حتى الآن.
- هناك بعض الأدوية لعلاج الإيدز ولكن نتائجها ليست دائما علاجية.

أسئلة

1. ما هي أهداف دراسة الأمراض الجلدية في كلية التمريض؟
2. كيف يتم علاج الجرب؟
3. ما هي أعراض الجرب؟
4. قائمة أعراض قمل الرأس؟
5. كيف ينتقل قمل الرأس؟
6. ما هو علاج الثآليل التناسلية؟
7. ما هي أعراض الجدري المائي؟
8. ما هي أعراض الهربس البسيط؟
9. كيف يتم علاج التهابات الجلدية البكتيرية؟
10. ما هي أنواع سعة الرأس؟ وكيف يتم التعامل معهم؟
11. قائمة الأمراض الجلدية الفطرية التي تصيب سطح الجلد؟
12. ما هو علاج قدم الرياضي؟
13. ما هي أعراض سعة المبرقشة؟ وكيف يتم علاجه؟
14. أذكر بعض الأمراض الجلدية غير المعدية وشرح أحدها؟
15. قائمة أعراض الصدفية؟
16. كيف يتم علاج الصدفية؟
17. ما هي أعراض البهاق؟
18. ما هو علاج حب الشباب؟
19. وصف علاج أمراض الجلد الفقاعية؟
20. كيف يتم علاج الشرى؟
21. ما هي أعراض الشرى الحطاطي؟
22. كيف يتم علاج الشرى الحطاطي؟
23. أذكر أنواع الأكزيما التي تصيب الجلد في المراحل العمرية المختلفة؟
24. ما هو علاج الأكزيما؟
25. ما هي أسباب ظهور الشعر الزائد عند النساء؟
26. كيف يتم علاج الشعرانية عند النساء؟
27. ما هي أنواع الثعلبة التي تصيب الشعر؟
28. ما هي طرق علاج الثعلبة؟
29. أذكر مراحل مرض الزهري المكتسب؟

30. ما هي مراحل مرض الزهري الخلقي؟
31. ما هي أعراض مرض السيلان الحاد عند الرجال؟
32. ما هي أعراض مرض السيلان الحاد عند النساء؟
33. كيف يتم علاج مرض السيلان؟
34. ما هي أعراض متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)؟
35. ما هو علاج الإيدز؟

ضع علامة (✓) على العبارة الصحيحة و (×) على العبارة غير الصحيحة.

1. الجرب هو مرض فيروسي ينتقل عن طريق الاتصال.
2. يتم علاج الجرب بإعطاء أقراص جريسوفولفين.
3. فترة حضانة الجرب هي خمسة أيام.
4. ينتقل الجرب عن طريق الاتصال.
5. يسبب قمل الرأس تورم الغدد الليمفاوية في الرقبة.
6. ينتقل جدري الماء عن طريق الرذاذ.
7. يصاحب الهريس النطاقي ألم شديد في موقع الحويصلات.
8. يتم علاج التآليل عن طريق إعطاء المضادات الحيوية.
9. يمكن استخدام الليزر لعلاج التآليل.
10. يستخدم محلول بودوفيلين لعلاج التآليل التي تصيب الأعضاء التناسلية.
11. يصاحب مرض الجدري المائي حمى خفيفة.
12. يتم علاج سعفة الرأس عن طريق إعطاء أقراص جريسوفولفين.
13. يسبب مرض فافوس (سعفة فافوسا) تلف بصيلات الشعر.
14. يتطلب علاج سعفة الأظافر (فطريات الأظافر) فترة طويلة.
15. يتم علاج سعفة المبرقشة بإعطاء أقراص جريسوفولفين.
16. الصدفية مرض معدٍ ينتقل عن طريق الاتصال.
17. البهاق هو مرض جلدي معدي.
18. يظهر البهاق على شكل بقع بيضاء على الجسم.
19. ينتشر البهاق عن طريق الرذاذ.
20. يتم علاج البهاق عن طريق إعطاء أقراص السورالين (على سبيل المثال، الملادينين).
21. الصدفية لا تؤثر على فروة الرأس أو الأظافر.
22. يتم مراقبة ضغط الدم بشكل دوري في حالات أمراض الجلد الفقاعية.

23. يتم علاج أمراض الجلد الفقاعية بإعطاء جرعات عالية من الكورتيزون.

24. يتضمن علاج الشرى الحاد إعطاء حقنة الأدرينالين تحت الجلد.

25. يتم علاج الشرى عن طريق إعطاء الأدوية المضادة للفيروسات.

26. يمكن أن تؤدي لدغات الحشرات والبعوض إلى الشرى الحطاطي.

27. الشرى الحطاطي لا يصيب الأطفال.

28. الأكزيما مرض معد يصيب الجلد.

29. تظهر الأكزيما التي تصيب الأطفال دون سن الثانية على الوجه.

30. حب الشباب هو نتيجة لزيادة إفراز الأندروجينات.

31. الثعلبية البقعية هي مرض معد يؤدي إلى تساقط الشعر.

32. زيادة إفراز الأندروجينات يؤدي إلى زيادة الشعر عند النساء (الشعرانية).

33. يستخدم الليزر لعلاج الشعر الزائد.

34. ينتقل مرض الزهري عن طريق الاتصال الجنسي.

35. المرحلة الأولى من مرض الزهري المكتسب تسمى القرحة (القرحة الصلبة).

36. فترة حضانة مرض السيلان تتراوح من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

37. يتم علاج مرض السيلان بالمضادات الحيوية.

38. الإيدز مرض طفيلي.

39. تتم السيطرة على مرض الإيدز عن طريق لقاح وقائي ضد المرض.

40. يرتبط الإيدز بفقدان الوزن.

مفهرس

جدول المحتويات

- مقدمة الكتاب
- الحصانة العامة

الفصل الأول:

-أمراض الدورة الدموية

1. ألم في الصدر
- 2.مرض القلب الإقفاري
3. ارتفاع ضغط الدم
4. سكتة قلبية
5. أمراض التامور والشغاف

الفصل الثاني:

- أمراض الجهاز التنفسي

1. الربو القصبي
2. السل الرئوي
3. الالتهاب الرئوي
4. التهاب الشعب الهوائية المزمن وانتفاخ الرئة

الفصل الثالث:

- أمراض الجهاز الهضمي

5. قرحة المعدة وقرحة الاثني عشر
6. الإسهال الحاد

الفصل الرابع:

- التهاب الكبد الفيروسي

1. التهاب الكبد الفيروسي الحاد
2. التهاب الكبد الفيروسي المزمن
3. البلهارسيا
4. أسسديتيس
5. غيبوبة الكبد (اعتلال الدماغ الكبدي)

الفصل الخامس:

- الجهاز البولي

1. التهاب الحويضة والكلية الحاد
2. الفشل الكلوي المزمن

الفصل السادس:

- أمراض الدم

1. فقر الدم
2. نقل الدم ومنتجاته.

3. سرطان الدم (اللوكيميا)

4. معدل النزيف

الفصل السابع:

– أمراض الغدد الصماء

1. الوطاء

2. أمراض الغدة الدرقية

3. داء السكري (DM)

الفصل الثامن:

– الأمراض المعدية

1. حمى التيفوئيد

2. الحصبة

3. الحصبة الألمانية (الحصبة الألمانية)

4. النكاف

الفصل التاسع:

– أمراض الجهاز العصبي

1. كوما

2. التهاب السحايا

الفصل العاشر:

– الأمراض الجلدية والتناسلية

1. الأمراض الجلدية الناجمة عن الالتهابات الطفيلية

2. الأمراض الجلدية الناجمة عن الالتهابات الفيروسية

3. الأمراض الجلدية الناجمة عن الالتهابات البكتيرية

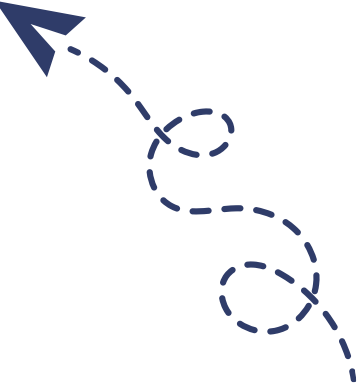
4. الأمراض الجلدية الناجمة عن الالتهابات الفطرية

– الالتهابات الفطرية السطحية للجلد

– المظاهر الجلدية المصاحبة لبعض الأمراض الداخلية

– الأمراض التناسلية (المنقولة جنسياً)

– أسئلة



لمزيد من الملاحظات والكتب الطبية
يُرجى زيارة قناة ثانية تمريضيانو
على تطبيق التليجرام



للاضمام إلى القناة، يُرجى النقر على زر subscribe